

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ENVELHECIMENTO HUMANO

KARINE PALUDO

VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR
CONTRA A PESSOA IDOSA:
PERCEPÇÃO E ESTRATÉGIAS DE
INTERVENÇÃO

Passo Fundo

2026



UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO
INSTITUTO DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENVELHECIMENTO HUMANO

KARINE PALUDO

VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR CONTRA A PESSOA IDOSA: PERCEPÇÃO E
ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO

Dissertação apresentada como requisito para
obtenção do título de Mestre em
Envelhecimento Humano, do Instituto da Saúde
da Universidade de Passo Fundo.

Orientadora: Dra. Profa. Graciela De Brum Palmeiras
Coorientadora: Dra. Profa. Adriana Fasolo Pilati

Passo Fundo

2026

ATA DE APROVAÇÃO



ATA DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO

“VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR CONTRA A PESSOA IDOSA: PERCEPÇÃO E ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO”

Elaborada por

KARINE PALUDO

Como requisito parcial para a obtenção do grau de
“Mestre em Envelhecimento Humano”

Aprovada em: 13/03/2026
Pela Banca Examinadora

Profa. Dra. Graciela De Brum Palmeiras
Universidade de Passo Fundo – UPF/PPGEH
Orientadora e Presidente da Banca Examinadora

Profa. Dra. Adriana Fasolo Pilati
Universidade de Passo Fundo – UPF/PPGD
Coorientadora

Profa. Dra. Siomara Regina Hahn
Universidade de Passo Fundo – UPF/PPGEH
Avaliadora Interna

Profa. Dra. Geraldine Alves Dos Santos
Universidade FEEV/ALE
Avaliadora Externa

Profa. Dra. Lia Mara Wibelinger
Universidade de Passo Fundo – UPF/PPGEH
Coordenadora PPGEH

ATA DE DEFESA - Karine.doc

Documento número #845a1eab-b09c-4780-aae8-baf73817edc9
Hash do documento original (SHA256): 3e1fa430e70dd242b9effd3db41c969ffa64b2060255223938f7c14205d7e20b

Assinaturas

-  **Lia Mara Wibelinger**
CPF: 518.452.290-53
Assinou em 17 mar 2026 às 09:26:56
-  **Graciela De Brum Palmeiras**
CPF: 963.653.400-44
Assinou em 17 mar 2026 às 14:02:36
-  **ADRIANA FASOLO PILATI**
CPF: 641.884.770-91
Assinou em 17 mar 2026 às 14:09:22
-  **Geraldine Alves dos Santos**
CPF: 632.019.500-25
Assinou em 17 mar 2026 às 20:31:02
-  **Siomara Regina Hahn**
CPF: 493.829.770-15
Assinou em 18 mar 2026 às 15:15:47

Log

- 17 mar 2026, 09:18:15 Operador com email dionice@upf.br na Conta c44b96f0-ca8e-4abe-b87d-0aed928844cd criou este documento número 845a1eab-b09c-4780-aae8-baf73817edc9. Data limite para assinatura do documento: 22 de abril de 2026 (10:30). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 17 mar 2026, 09:25:22 Operador com email dionice@upf.br na Conta c44b96f0-ca8e-4abe-b87d-0aed928844cd alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 30 de abril de 2026 (10:30).

17 mar 2026, 09:25:22	Operador com email dionice@upf.br na Conta c44b96f0-ca8e-4abe-b87d-0aed928844cd adicionou à Lista de Assinatura: gracielabrum@upf.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Graciela De Brum Palmeiras.
17 mar 2026, 09:25:22	Operador com email dionice@upf.br na Conta c44b96f0-ca8e-4abe-b87d-0aed928844cd adicionou à Lista de Assinatura: apilati@upf.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ADRIANA FASOLO PILATI.
17 mar 2026, 09:25:22	Operador com email dionice@upf.br na Conta c44b96f0-ca8e-4abe-b87d-0aed928844cd adicionou à Lista de Assinatura: siomara@upf.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Siomara Regina Hahn.
17 mar 2026, 09:25:22	Operador com email dionice@upf.br na Conta c44b96f0-ca8e-4abe-b87d-0aed928844cd adicionou à Lista de Assinatura: geraldinesantos@feevale.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Geraldine Alves dos Santos.
17 mar 2026, 09:25:22	Operador com email dionice@upf.br na Conta c44b96f0-ca8e-4abe-b87d-0aed928844cd adicionou à Lista de Assinatura: liafisio@upf.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Lia Mara Wibelinger.
17 mar 2026, 09:26:56	Lia Mara Wibelinger assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail liafisio@upf.br. CPF informado: 518.452.290-53. IP: 189.7.195.45. Componente de assinatura versão 1.1405.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
17 mar 2026, 14:02:36	Graciela De Brum Palmeiras assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail gracielabrum@upf.br. CPF informado: 963.653.400-44. IP: 186.223.240.47. Componente de assinatura versão 1.1405.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
17 mar 2026, 14:09:22	ADRIANA FASOLO PILATI assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail apilati@upf.br. CPF informado: 641.884.770-91. IP: 168.205.245.125. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.008137843618 e longitude -47.14869506596658. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1405.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
17 mar 2026, 20:31:02	Geraldine Alves dos Santos assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail geraldinesantos@feevale.br. CPF informado: 632.019.500-25. IP: 45.173.250.11. Componente de assinatura versão 1.1405.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
18 mar 2026, 15:15:47	Siomara Regina Hahn assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail siomara@upf.br. CPF informado: 493.829.770-15. IP: 177.75.148.43. Componente de assinatura versão 1.1406.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

18 mar 2026, 15:15:50

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 845a1eab-b09c-4780-aae8-baf73817edc9.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 845a1eab-b09c-4780-aae8-baf73817edc9, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

FICHA CATALOGRÁFICA

CIP – Catalogação na Publicação

P184v Paludo, Karine

Violência intrafamiliar contra a pessoa idosa [recurso eletrônico] : percepção e estratégias de intervenção / Karine Paludo – 2026.
5.1 MB ; PDF.

Orientadora: Profa. Dra. Graciela De Brum Palmeiras.
Coorientadora: Profa. Dra. Adriana Fasolo Pilati.
Dissertação (Mestrado em Envelhecimento Humano) – Universidade de Passo Fundo, 2026.

1. Envelhecimento. 2. Idosos - Maus-tratos. 3. Violência doméstica. 4. Cuidados primários de saúde. I. Palmeiras, Graciela de Brum, orientadora. II. Pilati, Adriana Fasolo, coorientadora. III. Título.

CDU: 613.98

Catalogação: Bibliotecária Juliana Langaro Silveira – CRB 10/2427

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho a todos os profissionais que estão na linha de frente no atendimento à pessoa idosa e que, para além da sua formação, possuem um olhar integral para o cuidado, acompanhados de uma busca incansável por oferecer o seu melhor a cada dia. Sobretudo, àqueles que não se calam diante de situações de suspeita ou confirmação de violência contra a pessoa idosa.

AGRADECIMENTOS

Inicialmente, agradeço à minha coragem e persistência, pois, mesmo após alguns anos de formada, mantive vivo em mim o desejo de fazer o mestrado, o mesmo que surgiu ao concluir a graduação. Após muitos percalços da vida, compreendi que havia chegado a hora de encarar esse desafio, iniciado em 2024.

Agradeço à Universidade de Passo Fundo, que me concedeu uma bolsa de estudos e tornou possível a concretização deste sonho.

Aos profissionais que prontamente aceitaram participar da pesquisa, trazendo contribuições valiosas com suas percepções e revelando preocupações que evidenciam a urgência de tratarmos desta temática.

À minha família, meus pais e irmãos, que sempre compreenderam a importância do mestrado para mim e estiveram ao meu lado em todas as etapas. Ao Franciel, pelo apoio constante e incentivo, lembrando-me que eu deveria, sim, seguir esse caminho e mostrando, a cada instante, o quanto eu era capaz.

À minha ex-colega e amiga Rosane, que me motivou a fazer a inscrição e contribuiu nesta jornada. Às minhas amigas de vida, Andreia, Gi e Fabieli, com quem compartilhei os desafios e conquistas do mestrado.

Aos amigos e colegas que o mestrado me presenteou, em especial às colegas de orientação, Larissa, Ana Paula e Stephanie, pelas trocas, pelo apoio e pelas risadas. Obrigada pela parceria incrível, que tornou este processo mais leve.

Por fim, minha eterna gratidão à orientadora, Graciela de Brum Palmeiras, pelo carinho, afeto e orientações incansáveis, mas, sobretudo, pelo rico processo de trocas e pelo apoio constante. Não há palavras que expressem o quanto foste importante.

RESUMO

Paludo, Karine. Violência intrafamiliar contra a pessoa idosa [recurso eletrônico]: percepção e estratégias de intervenção/Karine Paludo – 2026.

O envelhecimento populacional traz novos desafios sociais, entre eles o aumento da violência intrafamiliar contra a pessoa idosa, exigindo atuação integrada da rede de proteção, visando garantir direitos, segurança e dignidade. O estudo tem como objetivo compreender a repercussão da violência intrafamiliar na vida das pessoas idosas e analisar, à luz das evidências científicas e da percepção dos profissionais da rede de proteção, os fatores de risco e de proteção, bem como as estratégias de intervenção utilizadas nas situações de suspeita ou confirmação dessa violência. Trata-se de um estudo misto, descritivo, exploratório-analítico, de abordagem quantitativa e qualitativa e de cunho transversal. A pesquisa foi realizada com 38 profissionais que atuam na rede de proteção de um município localizado ao norte do Rio Grande do Sul. Os dados foram coletados por meio de um questionário semiestruturado desenvolvido na plataforma *Google Forms* e enviado via *WhatsApp* e/ou *e-mail*. A produção científica I trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura; a produção científica II, estudo de cunho quantitativo, cuja análise estatística foi conduzida no *software* JASP, com nível de significância de $\alpha = 0,05$ e na produção científica III, de abordagem qualitativa, a análise foi conduzida por meio da técnica de análise de conteúdo de Bardin, com auxílio do *software* NVivo 10. O estudo atendeu a Resolução nº 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709/2018. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com o parecer número 7.250.207. Evidenciou-se que a violência contra as pessoas idosas é multifatorial, frequentemente perpetrada por familiares e suas consequências incluem sofrimento emocional, adoecimento físico e redução da qualidade de vida. A maioria dos profissionais participantes do estudo era do gênero feminino (78,9%). 57,9% afirmaram nunca ter realizado intervenção e 55,3% referiram sentir-se capacitados para realizar intervenção ou encaminhamento em situação de violência contra a pessoa idosa. Os profissionais da Atenção Primária à Saúde e os que já realizaram intervenção apresentaram maior percepção dos fatores de proteção. Na análise lexical evidenciou a centralidade do termo “Violência”, articulando-se com as palavras “Social”, “Apoio” e “Idoso”. A análise de *Cluster* demonstrou correlação perfeita ($r=1$) entre as cinco categorias (nós) que surgiram: conhecimento e percepção sobre violência intrafamiliar; percepção das intervenções; estratégias de intervenção; necessidade de capacitação e qualificação; divulgação e prevenção quanto à violência intrafamiliar. O estudo apresentou reflexões sobre as repercussões da violência intrafamiliar na vida da pessoa idosa e o trabalho dos profissionais da Atenção Primária à Saúde e da rede intersetorial. Identificou-se que os profissionais da Atenção Primária à Saúde e os que relataram ter realizado alguma intervenção apresentaram maior percepção dos fatores de proteção. Evidenciou-se a complexidade do fenômeno da violência e que as estratégias de intervenção constituem um conjunto de ações articuladas. Destacou-se, ainda, a importância da capacitação profissional e articulação da rede de proteção. Ressalta-se a necessidade de implementação e fortalecimento de Políticas públicas que promovam ações intersetoriais.

Palavras-chave: Envelhecimento Humano; Pessoa idosa; Violência intrafamiliar; Atenção Primária à Saúde; Rede Intersetorial.

ABSTRACT

Paludo, Karine. Violência intrafamiliar contra a pessoa idosa [recurso eletrônico]: percepção e estratégias de intervenção/Karine Paludo – 2026.

Population aging brings new social challenges, including an increase in domestic violence against the elderly, requiring integrated action from the protection network to guarantee rights, safety, and dignity. This study aims to understand the impact of domestic violence on the lives of elderly people and to analyze, in light of scientific evidence and the perception of professionals in the protection network, the risk and protective factors, as well as the intervention strategies used in situations of suspected or confirmed violence. This is a mixed-methods, descriptive, exploratory-analytical study with a quantitative and qualitative approach and a cross-sectional design. The research was conducted with 38 professionals working in the protection network of a municipality located in northern Rio Grande do Sul. Data were collected through a semi-structured questionnaire developed on the Google Forms platform and sent via WhatsApp and/or email. The scientific production I is an Integrative Literature Review; Scientific Production II, a quantitative study, whose statistical analysis was conducted using JASP software, with a significance level of $\alpha = 0.05$, and Scientific Production III, a qualitative study, whose analysis was conducted using Bardin's content analysis technique, with the aid of NVivo 10 software. The study complied with Resolution No. 466/2012 of the National Health Council and the General Law on the Protection of Personal Data, Law No. 13.709/2018. The research project was approved by the Research Ethics Committee with opinion number 7.250.207. It was evidenced that violence against older people is multifactorial, frequently perpetrated by family members, and its consequences include emotional suffering, physical illness, and reduced quality of life. The majority of professionals participating in the study were female (78.9%). 57.9% stated they had never intervened, and 55.3% reported feeling capable of intervening or referring individuals in situations of violence against the elderly. Primary Health Care professionals and those who had already intervened showed a greater awareness of protective factors. Lexical analysis highlighted the centrality of the term "Violence," articulating with the words "Social," "Support," and "Elderly." Cluster analysis demonstrated a perfect correlation ($r=1$) between the five categories (nodes) that emerged: knowledge and perception of domestic violence; perception of interventions; intervention strategies; need for training and qualification; dissemination and prevention of domestic violence. The study presented reflections on the repercussions of domestic violence on the lives of the elderly and the work of Primary Health Care professionals and the intersectoral network. It was identified that Primary Health Care professionals and those who reported having intervened showed a greater awareness of protective factors. The complexity of the phenomenon of violence was highlighted, and intervention strategies constitute a set of coordinated actions. The importance of professional training and the coordination of the protection network was also emphasized. The need for the implementation and strengthening of public policies that promote intersectoral actions is stressed.

Keywords: Human Aging; Elderly Person; Domestic Violence; Primary Health Care; Intersectoral Network.

LISTA DE SIGLAS

ABVD	Atividades Básicas da Vida Diária
AIVD	Atividades Instrumentais da Vida Diária
APS	Atenção Primária à Saúde
BVS	Biblioteca Virtual em Saúde
CAFe	Comunidade Acadêmica Federada
CAPES	Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CIPDI	Centro Integrado de Proteção e Defesa do Idoso
CRAS	Centro de Referência de Assistência Social
CREAS	Centro de Referência Especializado de Assistência Social
DECCI	Delegacia Especializada em Crimes Contra a Pessoa Idosa
DECs	Descritores em Ciências da Saúde
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IF	Incapacidade Funcional
ILPI	Instituição de Longa Permanência para Idosos
JASP	<i>Jeffreys's Amazing Statistics Program</i>
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados
OMS	Organização Mundial da Saúde
ONDH	Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos
PICo	População, Intervenção, Comparação/Controle, Desfecho/Outcome
RIL	Revisão Integrativa de Literatura
SCFV	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
SUAS	Sistema Único de Assistência Social
SUS	Sistema Único de Saúde
TCLE	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
UBS	Unidade Básica de Saúde

VCPI Violência Contra Pessoa Idosa

LISTA DE SÍMBOLOS

α Alfa de Cronbach

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	18
2	REVISÃO DE LITERATURA.....	22
2.1	PESSOA IDOSA E RELAÇÕES FAMILIARES NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA	22
2.2	LEGISLAÇÃO E REPERCUSSÃO DA VIOLÊNCIA NA VIDA DAS PESSOAS IDOSAS	26
2.3	O PAPEL DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE PROTEÇÃO DIANTE DA VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR CONTRA A PESSOA IDOSA.....	30
3	PRODUÇÕES CIENTÍFICAS.....	35
3.1	PRODUÇÃO CIENTÍFICA I: VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR CONTRA A PESSOA IDOSA:IMPLICAÇÕES NA VIDA DA VÍTIMA E ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS.....	35
3.2	PRODUÇÃO CIENTÍFICA II: PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE PROTEÇÃO SOBRE OS FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO NA VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR CONTRA A PESSOA IDOSA.....	36
3.3	PRODUÇÃO CIENTÍFICA III: ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO À PESSOA IDOSA NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR	37
4	CONSIDERAÇÕES FINAIS	38
	REFERÊNCIAS	40
	APÊNDICES	48
	Apêndice A. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.....	49
	Apêndice B. Questionário Semiestruturado	53
	Apêndice C. Carta de Anuência Fórum.....	61
	Apêndice D. Carta de Anuência Delegacia de Polícia Civil	64
	Apêndice E. Carta de Anuência Prefeitura Municipal de Três Palmeiras	67
	ANEXOS	70
	Anexo A. Parecer Consubstanciado do CEP	71
	Anexo B. Autorização para Realização da Pesquisa Fórum	77
	Anexo C. Autorização para Realização da Pesquisa Delegacia de Polícia Civil	79
	Anexo D. Autorização para Realização da Pesquisa Prefeitura Municipal de Três Palmeiras.....	81

1 INTRODUÇÃO

As pessoas idosas fazem parte do grupo populacional que está crescendo em todo o mundo, impulsionado por avanços significativos na medicina e pelo aumento da expectativa de vida. No Brasil, de acordo com o Censo Demográfico de 2022, a população com 60 anos ou mais aumentou 56,0% em relação a 2010, passando a representar 15,6% da população total. Em contrapartida, observa-se a redução da população de 0 a 14 anos de idade, que correspondia a 24,1% em 2010 e diminuiu para 19,8% em 2022 (IBGE, 2022).

Apesar das melhorias nas condições de saúde e qualidade de vida das pessoas idosas, os registros de violência contra a pessoa idosa têm aumentado. Entre 2002 e 2015, a prevalência global de abuso foi estimada em 15,7%, o que corresponde a um em cada seis adultos com mais de 60 anos, equivalente a aproximadamente 141 milhões de vítimas (Yon, 2017).

No Brasil, a violência contra pessoas idosas começou a ganhar maior visibilidade a partir da década de 1990, com a criação da Política Nacional do Idoso. Em 2003, foi promulgado o Estatuto do Idoso (Lei nº10.741/2003), seguido pela publicação do Plano de Ação de Enfrentamento à Violência Contra o Idoso em 2006. Posteriormente, em 2014, o Governo Federal lançou o Manual de Enfrentamento à Violência Contra a Pessoa Idosa. Mais recentemente, em julho de 2022, a Lei nº14.423, alterou a Lei nº 10.741/2003 do Estatuto do Idoso, substituindo os termos “idoso” e “idosos” por “pessoa idosa” e “pessoas idosas”, com objetivo de ampliar a representatividade e a inclusão.

Dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH) evidenciam a gravidade do problema. Em 2024, foram registradas 179.615 denúncias de violações de direitos contra a pessoa idosa no Brasil, das quais 10.698 ocorreram no Rio Grande do Sul. Em 2025, o número aumentou para 180.004 denúncias, sendo 11.562 no mesmo estado, demonstrando crescimento expressivo nas notificações de realizadas por meio do canal de denúncia Disque 100.

Significativa parte desses casos caracteriza-se como violência intrafamiliar, definida como qualquer ação ou omissão que comprometa o bem-estar e a integridade física ou psicológica de um membro da família. Essa violência pode ocorrer dentro ou fora do domicílio, sendo praticada por familiares ou por pessoas que assumem funções parentais, mesmo sem laços de consanguinidade, em relações de poder e dependência (Brasil, 2014).

Os profissionais que atuam diretamente no atendimento à população idosa desempenham papel essencial na observação, identificação e intervenção em situações de suspeita ou confirmação de violência. A rede de proteção, composta por profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), realiza atendimentos individualizados, coletivos e visitas domiciliares. Nos casos de violência, esses profissionais devem estar capacitados para realizar intervenções e encaminhamentos adequados. Além disso, outros órgãos, como o Judiciário, Delegacias de Polícia Civil, Brigada Militar, Ministério Público e Defensoria Pública, possuem atribuições relevantes, sendo responsáveis pela formalização das denúncias e pela investigação, dando continuidade ao atendimento inicial.

No contexto da violência contra pessoas idosas, Santos *et al.* (2020) identificaram fatores associados, tais como idade, sexo, estado civil, nível de escolaridade, renda, arranjo familiar, suporte social, solidão, transtornos mentais, depressão e dependência para atividades da vida diária. Já Bolkan, Teaster e Ramsey-Klawnsnik (2023) destacam como fatores de risco mais consistentes o apoio social limitado, o isolamento da vítima e a exposição prévia a eventos traumáticos. Entre os fatores de proteção, incluem-se o bom funcionamento cognitivo e o acesso a múltiplos apoios sociais e comunitários.

Desta forma, a violência contra a pessoa idosa configura-se como um grave problema social e de saúde pública, com consequências significativas para a saúde física, mental e para a qualidade de vida das vítimas. Este estudo se justifica pela relevância das estratégias de intervenção dos profissionais na prevenção e redução da incidência de violência intrafamiliar contra as pessoas idosas e tem como pergunta de pesquisa: qual a percepção dos profissionais

que compõem a rede de proteção e as estratégias de intervenção utilizadas nas situações de suspeita ou confirmação de violência intrafamiliar contra a pessoa idosa?

Diante do exposto, esta dissertação de mestrado teve como objetivo geral compreender a repercussão da violência intrafamiliar na vida das pessoas idosas e analisar, à luz das evidências científicas e da percepção dos profissionais da rede de proteção, os fatores de risco e de proteção, bem como as estratégias de intervenção utilizadas nas situações de suspeita ou confirmação dessa violência. E objetivos específicos: conhecer as evidências científicas disponíveis na literatura sobre a repercussão da violência intrafamiliar na vida das pessoas idosas e as estratégias de intervenção utilizadas pelos profissionais da rede de proteção; analisar a percepção dos profissionais quanto aos fatores de risco e de proteção e as intervenções no atendimento a violência intrafamiliar contra a pessoa idosa; e verificar a percepção dos profissionais que compõem a rede de proteção e as estratégias de intervenção utilizadas nas situações de suspeita ou confirmação de violência intrafamiliar contra a pessoa idosa.

Trata-se de uma pesquisa de campo de natureza mista e delineamento transversal, realizada com 38 profissionais que atuam na rede de proteção, incluindo Atenção Primária à Saúde e demais profissionais da rede intersetorial (Sistema Único de Assistência Social, Judiciário, Delegacia de Polícia Civil e Brigada Militar). Os dados foram coletados por meio de questionário semiestruturado, elaborado na plataforma *Google Forms* e enviada via aplicativo *WhatsApp* e *e-mail*. O instrumento contemplou questões sociodemográficas e específicas, com perguntas de múltipla escolha e abertas, permitindo que os profissionais discorressem livremente sobre suas percepções referentes a temática.

A análise quantitativa foi conduzida pelo *software JASP - Jeffreys's Amazing Statistics Program* (v.0.16.4). A caracterização da amostra foi feita por estatística descritiva, utilizando frequências para variáveis categóricas e média e desvio padrão para variáveis contínuas. Na estatística inferencial, aplicaram-se testes de normalidade (Shapiro-Wilk) e homogeneidade de variâncias

(Levene). Para comparar médias entre grupos independentes, utilizou-se o teste *t* de Student, e aplicou-se o teste *t* de Welch para assegurar a confiabilidade dos resultados. As associações entre variáveis categóricas foram verificadas pelo Qui-Quadrado de Pearson (X^2) ou pelo teste Exato de Fisher. Para todos os testes, foi adotado um nível de significância de $\alpha = 0,05$, considerando estatisticamente significativos os resultados com $p < 0,05$.

A análise qualitativa seguiu a técnica de análise de conteúdo de Bardin, com o auxílio do *software* NVivo 10, que possibilitou a organização, codificação e interpretação dos dados. As respostas discursivas dos participantes foram utilizadas para ilustrar categorias, e o coeficiente de correlação de Pearson para explorar padrões.

A presente dissertação está organizada da seguinte maneira: introdução, revisão de literatura sobre o tema da pesquisa, a produção científica I trata-se de um artigo de Revisão Integrativa da Literatura, a produção científica II consiste em um artigo de abordagem quantitativa, que reúne dados sobre o perfil dos profissionais, a percepção quanto aos fatores de risco e proteção e das intervenções no atendimento a violência intrafamiliar contra a pessoa idosa. A produção III, refere-se a um artigo de natureza qualitativa, baseado nas respostas discursivas sobre o tema. Por fim, nas considerações finais, são apontados os principais achados, destacando-se as contribuições do estudo e possíveis desdobramentos para pesquisas futuras.

2 REVISÃO DE LITERATURA

A presente revisão de literatura aborda a temática da pessoa idosa e suas relações familiares no contexto da violência, bem como a conceituação e as legislações referentes à violência contra esse grupo etário e suas repercussões na vida das vítimas. Além disso, discute-se o papel dos profissionais da rede de proteção e o atendimento prestado no enfrentamento das violações de direitos das pessoas longevas.

2.1 *Pessoa idosa e relações familiares no contexto da violência*

Neste item serão abordados aspectos relacionados ao processo de envelhecimento, com foco na velhice como fase da vida e nos estigmas a ela associados, assim como nas relações familiares das pessoas idosas e no contexto da violência.

Entender o envelhecimento humano envolve um conjunto de conhecimentos de natureza multidimensional. Trata-se de um processo pelo qual o ser humano passa desde o nascimento, configurando-se como um fenômeno universal e irreversível. Assim, o envelhecimento é um processo contínuo, no qual os sujeitos constroem suas experiências e estabelecem vínculos, valendo-se de recursos biológicos, culturais, sociais, econômicos e políticos. As bases desse processo são as modificações físicas que ocorrem no corpo (Doll *et al.*, 2016).

Sendo um processo natural, o envelhecimento na sociedade muitas vezes é visto por uma série de estereótipos e valorização excessiva da juventude. Baltes e Baltes (1991) referem que indivíduos que possuem visão positiva de sua própria imagem enfrentam os estereótipos da velhice de forma mais adequada, com maior autoestima, confiança na própria competência e autoeficácia, bem como senso de controle sobre suas ações e ambiente.

A velhice é cercada por questionamentos, dentre eles a busca por um envelhecimento saudável, carregado ao mesmo tempo pelo medo de envelhecer. Os sentimentos em relação à velhice podem ser permeados por

valores que oscilam entre o encanto e o terror, a aceitação e a rejeição, a valorização e a negação, o respeito e a desvalorização, dependendo do que conhecemos a seu respeito. Ou seja, os estereótipos criados em relação à velhice são desenvolvidos de acordo com a interpretação que é construída socialmente e culturalmente sobre ela (Moreno; Alves; Machado, 2020).

Os termos velho, idoso, envelhescente, melhor idade, maior idade e terceira idade são termos que costumam ser utilizados para se referir à mesma fase da vida. No entanto, as imagens do envelhecimento são marcadas por mudanças culturais que redefinem o modo de construção das identidades. A velhice é para além do aspecto biológico, refletindo aspectos socioculturais, relações sociais e de gênero (Cruz; Santos, 2021).

Para Faleiros (2023), o desgaste ou declínio do corpo é uma questão multidimensional e complexa, cada pessoa tem sua história social e individual, representada pela provisão ou falta de políticas públicas, como também o comportamento condicionado por determinações de classe, gênero e raça. Destacando que a velhice se estrutura como lugar de perdas, de decadência e falta de função social.

O contexto da velhice é permeado por estigmas que se podem ser observados nas relações familiares e como ela se auto-organiza. Rabelo (2016) destaca que o sistema familiar tem um conjunto invisível de regras que organizam as interações familiares, e a partir das características e qualidades destas relações os subsistemas familiares se organizam e se transformam ao longo do tempo. O curso de vida familiar é de longa duração, contextualizado, multidimensional, sujeito a ganhos e perdas e demarcado por eventos de transição. A velhice, como o último estágio do ciclo de vida, se caracteriza pelo rompimento com o trabalho formal, perda de independência/autonomia, e proximidade da morte, como também vivência do luto, seja de membros da família ou amigos. O que vai determinar esta fase da vida são as consequências de como as fases anteriores foram vividas, como por exemplo as interações familiares.

As famílias em situação de vulnerabilidade social acumulam situações de estresse, as quais envolvem más condições de vida e de trabalho, violência, instabilidade financeira e suscetibilidade a crises. Nestes grupos familiares, o ciclo de vida familiar tende a ser mais truncado, menos delineado, com fases mais curtas e com demarcação mais confusa de papéis. Pessoas idosas, por vezes têm a responsabilidade com filhos e netos, a aposentadoria representa importante fonte de sustento e muitos continuam trabalhando (Rabelo, 2016).

Esta população possui percepções diferentes quanto às interações familiares nesta fase da vida. Estudo apresentado por Colussi *et al.* (2019) identificou que pessoas idosas percebem o envelhecimento na convivência familiar como positivo, referindo a possibilidade de brincar com os netos e participar dos grupos de convivência, como forma de sociabilidade e superação da solidão pela ausência dos filhos. Ao mesmo tempo, o estudo identificou sentimentos contraditórios, como medo, solidão, fragilidade e dependência e, de outro lado, projeção de um envelhecer com coragem e felicidade. Já nas vivências familiares, apesar das pessoas idosas identificarem a família como espaço de cuidado, também, observou-se formas sutis e implícitas de violência psicológica, financeira e abandono. Sendo perceptível o sentimento de impotência e vergonha para tomar alguma atitude.

É nos mais diferentes contextos das relações familiares que a violência intrafamiliar pode se apresentar e se estabelecer ao longo do tempo. Estudos demonstram que o perfil do agressor e os tipos de violência praticados apresentam características comuns, como morar com a vítima; ser financeiramente dependente; abuso de álcool e drogas; vínculos familiares rompidos; pouca comunicação e afeto; isolamento social dos familiares da pessoa de idade avançada; história pregressa de violência na família; possuírem diagnóstico de depressão e ou outro diagnóstico de sofrimento mental ou psiquiátrico (Cruz; Santos, 2021).

Também, estudos de diferentes regiões do Brasil identificam que as mulheres idosas são principais vítimas de violência, na faixa etária acima de 70 anos, viúvas/divorciadas, aposentadas, com baixa renda e escolaridade,

comprometimento físico e/ou cognitivo, bem como coabitam com seus próprios agressores, que em geral são filhos com idade entre 40 e 49 anos (Morilla; Manso, 2021).

Em grupos familiares com pessoas idosas com suspeita ou vítimas de abusos, identifica-se correlação com sintomas psicopatológicos, como obsessão compulsiva, sensibilidade interpessoal, ansiedade, hostilidade e ideação paranóide. Em lares com baixa capacidade adaptativa pode ter sua funcionalidade diminuída, apresentando maior chance de ocorrer violência, com impacto negativo em quem a vivência, repercutindo no bem-estar mental e saúde física em geral. Nos ambientes familiares onde não ocorre violação de direitos, as relações familiares contribuem para o bem-estar da pessoa idosa, permitindo que seja mais funcional, o que é importante nesta fase da vida (Santa-cruz-espinoza; Saona-carril; Jara-barrena, 2022).

Quanto ao processo de cuidar da pessoa idosa, se observa que a família necessita de suporte profissional para responder a demanda da sobrecarga de atividade e estresse, que na maioria das vezes possui perda de capacidade funcional e de patologias associadas ao processo de envelhecimento. O cuidar, ao ser compartilhado por outros membros da família evita a sobrecarga física e emocional de um único familiar (Vale *et al.*, 2015).

Assim, o envelhecimento é um fenômeno multifacetado e multifatorial, o qual pode estar associado a doenças e incapacidades, que podem alterar o ciclo de vida dos sujeitos, tornando-os de independentes para dependentes, exigindo comportamentos e cuidados diferentes uns dos outros, afetando significativamente a autonomia e as questões relacionadas à convivência familiar.

No que tange a velhice na sociedade, pode se dizer que é vista como uma construção social marcada por estigmas, contribuindo para a discriminação e preconceito, principalmente daqueles que vivem e convivem com pessoas idosas. O cuidar da pessoa idosa perpassa por adaptação, podendo apresentar dificuldades e transformações no contexto das relações familiares e estilo de

vida dos seus membros, que por vezes assumem o papel do cuidar sem preparo e permeado por responsabilidades, relacionando e culminando em atos/ações de violência.

2.2 *Legislação e repercussão da violência na vida das pessoas idosas*

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a violência como uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou comunidade, que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. A violência é dividida em três categorias: 1) violência autoinfligida, que é a violência dirigida contra si mesmo e está subdividida em comportamento suicida e auto abuso; 2) violência interpessoal, subdividida em violência cometida por membros da família, parceiros íntimos e violência comunitária; 3) violência coletiva, subdividida em violência social, política e econômica (OMS, 2002).

A violência interpessoal é classificada em dois âmbitos: intrafamiliar e comunitária. A violência intrafamiliar diz respeito aquela que ocorre entre parceiros íntimos e/ou membros da família no ambiente doméstico. Em geral, quando em uma família se identifica alguma situação de abuso, com frequência, existe uma interrelação onde pode se identificar várias outras formas de violência. A violência comunitária, ocorre no ambiente social em geral, entre pessoas conhecidas e desconhecidas (Minayo, 2006).

As violências contra a pessoa idosa podem ser visíveis ou invisíveis: as visíveis são as mortes e lesões; as invisíveis são aquelas que ocorrem sem machucar o corpo, mas provocam sofrimento, desesperança, depressão e medo (Brasil, 2014). A violência contra este grupo etário é classificada em física, psicológica, sexual, negligência, autonegligência, abandono e exploração financeira.

A violência física se refere ao uso da força física para ferir, provocar dor, incapacidade ou morte ou para compelir a pessoa idosa a fazer o que não deseja

(Souza; Minayo, 2010). Se constitui como a forma de violência mais visível e costuma ocorrer por meio de empurrões, beliscões, tapas ou por outros meios mais letais, os quais podem resultar em lesões e traumas que levam a internação hospitalar ou até mesmo a morte da pessoa idosa (Brasil, 2014).

A violência psicológica, é caracterizada por agressões verbais ou gestuais com o objetivo de aterrorizar, humilhar, restringir a liberdade ou isolar o idoso do convívio social (Souza; Minayo, 2010). As pessoas idosas vítimas de violência psicológica podem ter repercussões graves nas suas vidas, como baixa autoestima, depressão, medo, dentre outros, podendo em muitos casos chegar até a cometer o suicídio (Moreno; Alves; Machado, 2020).

A violência sexual se refere a atos ou jogos sexuais de caráter homo ou heterorrelacional que utilizam pessoas idosas visando obter excitação, relação sexual ou práticas eróticas por meio de aliciamento, violência física ou ameaças (Souza; Minayo, 2010).

A negligência é um tipo de violência que se refere à recusa ou omissão de cuidados necessários ao idoso, podendo ser por parte de familiares ou instituições responsáveis. Enquanto a autonegligência diz respeito à conduta da pessoa idosa que ameaça sua própria saúde ou segurança por meio da recusa de prover a si mesma dos cuidados necessários. O abandono também é outro tipo de violência que consiste na ausência ou deserção dos responsáveis governamentais, institucionais ou familiares de prestarem socorro ao idoso que necessita de proteção (Souza; Minayo, 2010).

Quanto a violência financeira e econômica, é caracterizada pela exploração imprópria, ilegal ou não, consentida dos bens financeiros e patrimoniais do idoso (Souza; Minayo, 2010). A aposentadoria da pessoa idosa, na maioria das situações é a única renda fixa familiar e se torna a garantia de manutenção das despesas básicas. Diante disso, Ribeiro *et al.* (2021), em sua pesquisa realizada com amostra de 380 pessoas idosas, identificaram que a maioria possuía renda fixa de menos que dois salários-mínimos e que dividiam as despesas familiares, auxiliando no sustento da família.

Neste mesmo contexto, estudos identificaram que pessoas idosas com redução cognitiva e/ou comprometimento cognitivo leve possuem risco aumentado de sofrer exploração financeira. As mudanças cognitivas associadas ao envelhecimento e as doenças cerebrais podem prejudicar a capacidade de tomada de decisão, ocorrendo maior vulnerabilidade financeira. Além dos preditores cognitivos, fatores psicossociais, como depressão, sentimento reduzido de bem-estar, níveis mais baixos de apoio social e solidão também são importantes preditores. Assim, pessoas idosas experimentam mudanças no funcionamento cognitivo e socioemocional que podem levar a uma baixa capacidade de tomada de decisões, tendo risco aumentado de sofrer exploração financeira (Spreng; Karlawish; Marson, 2016).

A violência por ser marcada por invisibilidade, o silêncio por parte das vítimas se dá pelo medo de retaliação dos familiares ou até mesmo por não perceber o fenômeno como agressão ou violência devido aos vínculos familiares (Shimbo; Labronici; Mantovani, 2011). Diante disso, o fenômeno da violência pode trazer inúmeras implicações na saúde das vítimas.

Bomfim, Camargos e Zacrattos (2022), buscaram analisar a associação da violência no contexto intrafamiliar contra a pessoa idosa e a incapacidade funcional (IF), esta mensurada pelas atividades básicas da vida diária (ABVD) e atividades instrumentais da vida diária (AIVD). Em seus achados identificaram que há prevalência de violência cometida por filhos e netos e que a violência intrafamiliar tem associação significativa tanto a ABVD quanto a AIVD, sendo que a chance de ter IF são maiores entre aqueles que sofreram algum tipo de violência em relação a aqueles que não sofreram.

Neste contexto das mais variadas formas de violência contra a pessoa idosa e como afeta significativamente a vida dessas vítimas, o Estatuto da Pessoa Idosa, Lei nº 10.741/2023 e suas alterações na Lei nº 14.423/2022, apresenta:

Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a

efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária (Brasil, 2022, p. 1).

Art. 4º Nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei (Brasil, 2022, p.2).

Neste sentido, assegura-se à pessoa idosa, enquanto prioridade, a efetivação dos seus direitos e garantia de proteção frente à situação de violação de direitos. Ainda, a referida Lei, reforça a importância das instituições de saúde no atendimento às necessidades da pessoa idosa, a realização de treinamentos e capacitações aos profissionais, como também orientações aos cuidadores familiares e grupos de autoajuda. Ressaltando a obrigatoriedade de notificação, nos casos de suspeita ou confirmação de violência, dos profissionais da saúde pública e privada, às autoridades sanitárias, bem como a sua comunicação aos seguintes órgãos: Autoridade Policial; Ministério Público; Conselho Municipal do Idoso; Conselho Estadual do Idoso; Conselho Nacional do Idoso (Brasil, 2022).

No que diz respeito a políticas públicas que visam o bem-estar das pessoas idosas, Pereira *et al.* (2021) mencionam que muitas vezes não são totalmente implementadas, o que requer uma reorganização de ordem cultural no país, principalmente pela velhice ainda ser vista como um conjunto de perdas e fragilidades. Minayo (2016), questiona se é possível prevenir a violência e reforça a importância de ações estratégicas que possam beneficiar as pessoas idosas, como também toda a população. As ações estão relacionadas à implementação de políticas públicas, à nível institucional e no âmbito da cidadania. Neste sentido, se compreende a necessidade de articulações de vários órgãos públicos e dos cidadãos. Os profissionais são importantes elos de vínculos com as pessoas idosas e famílias e na realização de intervenções e ações socioeducativas no combate a violação de direitos.

Conclui-se que, apesar de se identificar a presença de legislações que visem o bem-estar e a proteção integral das pessoas idosas, ainda a violência é presente na vida de muitas pessoas, trazendo implicações nas condições de

saúde e qualidade de vida. Também se constata a necessidade de investimento em políticas públicas e ações de prevenção.

2.3 O papel dos profissionais da rede de proteção diante da violência intrafamiliar contra a pessoa idosa

A violência enquanto fenômeno sócio-histórico, não é somente uma questão de saúde pública e nem um problema médico típico. Ela vai afetar a saúde, podendo provocar morte, lesões, traumas físicos, psicológicos e diminuição da qualidade de vida das pessoas e da coletividade. A violência exige organização dos serviços de saúde e evidência a necessidade de uma atuação específica, interdisciplinar, multiprofissional e intersetorial visando às necessidades dos cidadãos (Minayo, 2006).

Os profissionais que trabalham na rede de atendimento dos municípios têm papel importante nas suas intervenções nos casos de suspeita ou confirmação de violação de direitos das pessoas idosas, bem como demais serviços da rede de proteção, como Delegacia de Polícia Civil, Defensoria Pública, Judiciário e Ministério Público.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) possuem aproximação direta com as famílias e nas questões que envolvem o contexto familiar. A UBS é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), composta por equipe multiprofissional, possuem posição estratégica que possibilita detectar situações potencialmente geradoras de violência intrafamiliar e possíveis vítimas, sendo de extrema relevância o relacionamento interpessoal entre profissional, idoso e família (Rocha *et al.*, 2015). Neste mesmo sentido, encontram-se os Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou os Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), dependendo do porte dos municípios, os quais também estão localizados próximos às populações mais vulneráveis e possuem ações de prevenção e superação de violações de direitos.

No que se refere ao atendimento direto às pessoas idosas vítimas de violência, estudo realizado em Hong Kong com profissionais da enfermagem e

serviço social destacou que o primeiro passo é realizar abordagem eficaz para identificação e estabelecer relação de confiança entre profissional e pessoa atendida. Também, menciona a importância de realizar avaliação abrangente e de risco do caso, bem como ter escuta atenta, proporcionando espaço seguro para a vítima contar sua história. Apoiar os cuidadores pode ajudar a prevenir o abuso de idosos, uma vez que os cuidadores sofrem frequentemente de estresse, e apoio às vítimas, garantindo segurança e suporte na sua vida diária. A abordagem multidisciplinar pode aumentar a eficiência no atendimento e melhorar os resultados da intervenção, uma vez que a responsabilidade de prevenir e intervir não deve recair sobre uma única profissão, sendo necessário esforço colaborativo de todos os setores da sociedade para proporcionar um ambiente seguro as pessoas idosas (Yan *et al.*, 2022).

Em outro estudo realizado em um departamento de emergência nos Estados Unidos identificou-se que muitas vezes os atendimentos a pessoas idosas passam despercebidos, sendo um espaço de potencial intervenção. Destaca-se que a avaliação profissional deve incluir observação de interação entre paciente e cuidador, histórico médico abrangente e exame físico. Os protocolos formais de triagem podem ser úteis e os profissionais devem documentar em detalhes suas observações. As intervenções dos profissionais devem incluir tratamentos de problemas médicos, traumáticos e psicológicos, garantindo segurança do paciente, como também a necessidade de reportar informações às autoridades (Rosen *et al.*, 2018).

A visita domiciliar também se apresenta como importante instrumento de trabalho para os profissionais dos diferentes setores, pois a mesma possibilita conhecer a realidade vivenciada pela família e construir estratégias eficazes. Rocha *et al.* (2015) destacam que os profissionais ao adentrar o domicílio promovem o cuidado com ações direcionadas à saúde, contemplando especificidades dos indivíduos e família como um todo. Para tanto, no que tange o enfrentamento a violência, requer dos serviços ações intersetoriais, pautadas na linearidade e articulação da área da saúde com outros serviços.

Barretto *et al.* (2020), em sua investigação identificou fragilidade na qualificação profissional e precariedade do conhecimento sobre o tema violência contra a pessoa idosa. Devido a estas lacunas, os profissionais referem que por não serem capacitados reconhecem que são negligentes, não atuando como deveriam, o que pode levar a consequente subnotificação.

Na mesma perspectiva, Swiech e Renk (2023) destacaram em seu estudo, quanto os profissionais da saúde que já enfrentaram situações de violência, os mesmos sentem desconforto moral, alguns mencionam angústia de não saber agir adequadamente, outros, a demora da vítima em procurar ajuda. Notando-se que os profissionais não ficam indiferentes à situação de violência, mas precisam de mais instrução para saber como agir. Ainda, grande parcela dos participantes do estudo não souberam dar encaminhamento, mantendo o caso na instituição. Evidenciando que a falta de educação (formal ou não formal) voltadas aos profissionais da saúde, gera desconforto e dificuldade na condução dos casos.

Serviços como Delegacia de Polícia, Defensoria Pública, Ministério Público e Judiciário, também são órgãos que apresentam ações de relevância no combate à violência deste grupo etário e obrigatoriamente articulam-se com os demais serviços municipais. Quanto às Delegacias de Polícia, são responsáveis por receber e apurar as denúncias. A Defensoria Pública visa assegurar a assistência jurídica gratuita e integral às pessoas idosas que comprovem a insuficiência de renda para arcar com as custas do processo e da contratação de um advogado particular. O Ministério Público é o órgão que trabalha preventivamente pequenos conflitos e situações que possam se agravar gerando casos de violência, bem como, tomam as providências judiciais e extrajudiciais em defesa das pessoas idosas. No âmbito do judiciário, tem por base a aplicação de medidas de proteção que visem ao combate e interrupção dos casos de violência (Secretaria de Estado da Saúde do Rio Grande do Sul, 2016).

Por vezes, se identifica falta de articulação efetiva com a rede de serviços e com os órgãos de proteção à pessoa idosa, necessitando de capacitação profissional e trabalho intersetorial, uma vez que a ausência de

interdisciplinaridade pode gerar ações pontuais e fragmentadas. Há muitos desafios e caminhos para o enfrentamento da violência intrafamiliar, sendo primordial a escuta qualificada, proteção aos profissionais que lidam com casos de violência, qualificação e capacitações contínuas e a relevância dos profissionais construírem vínculos com as famílias atendidas (Goes; Cezario, 2017)

A organização do fluxo de atendimento torna-se um importante meio para a comunicação entre os serviços de saúde, assistência social e demais órgãos. Sales *et al.* (2014), menciona que quando a violação de direito é identificada pelo serviço de saúde, sugere-se que o fluxo inicie pela comunicação da UBS a partir de um profissional como referência, posteriormente, comunicação com serviços do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), conforme a infraestrutura do município.

Os profissionais têm a responsabilidade ética e legal de identificar e relatar a suspeita de qualquer forma de violência às autoridades competentes, para que ocorra a investigação e ação dos serviços de proteção. Assim, o reconhecimento da violência contra a pessoa idosa por parte dos profissionais pode auxiliar na minimização dos danos gerados, como também na interrupção do ciclo da violência. No entanto, se reconhece as dificuldades neste processo, principalmente no que se refere à identificação da ocorrência da violência, no preenchimento da ficha de notificação e no desconhecimento das ações para prevenção e combate à violência (Goes; Cezario, 2017).

Observa-se que a maioria dos estudos direcionam que determinadas categorias profissionais são responsáveis pela identificação e intervenção, como por exemplo profissionais da enfermagem e serviço social. No entanto, todos os profissionais que de alguma forma possuem contato com a pessoa idosa precisam estar capacitados para realizarem o atendimento devido quando ocorre suspeita ou confirmação da violência. Também, é notável que se encontram fragilidades tanto na forma de identificação como nos encaminhamentos dos profissionais. Diante deste contexto, o estudo apresenta relevância científica e

social, e seus resultados poderão contribuir na busca de estratégias de intervenção, auxiliando na prevenção ou redução da incidência de violência intrafamiliar contra a pessoa idosa, bem como na criação de políticas públicas.

3 PRODUÇÕES CIENTÍFICAS

Nesta seção serão apresentadas as produções científicas que compõem esta dissertação, sendo elas: Produção científica I “Violência intrafamiliar contra a pessoa idosa: implicações na vida da vítima e estratégias de intervenção dos profissionais”, consiste em um estudo de Revisão Integrativa da Literatura. A produção científica II “Percepção dos profissionais da rede de proteção sobre os fatores de risco e proteção na violência intrafamiliar contra a pessoa idosa”, trata-se de um artigo de abordagem quantitativa, que reúne dados sociodemográficos, percepções quanto aos fatores de risco e de proteção e as intervenções no atendimento a violência intrafamiliar contra a pessoa idosa. A Produção científica III “Estratégias de intervenção da rede de proteção à pessoa idosa no contexto da violência intrafamiliar” refere-se a um artigo de natureza qualitativa, baseado nas respostas discursivas sobre o tema.

3.1 *Produção científica I:*

VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR CONTRA A PESSOA IDOSA: IMPLICAÇÕES NA VIDA DA VÍTIMA E ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS

DOMESTIC VIOLENCE AGAINST THE ELDERLY: IMPLICATIONS FOR THE VICTIM'S LIFE AND INTERVENTION STRATEGIES FOR PROFESSIONALS

VIOLENCIA DOMÉSTICA CONTRA LAS PERSONAS MAYORES: IMPLICACIONES PARA LA VIDA DE LA VÍCTIMA Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PARA PROFESIONALES

Capítulo omitido por questões de originalidade de produção científica.

3.2 *Produção científica II:*

**PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE PROTEÇÃO SOBRE OS
FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO NA VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR
CONTRA A PESSOA IDOSA**

**PERCEPTIONS OF PROFESSIONALS IN THE PROTECTION
NETWORK REGARDING RISK AND PROTECTIVE FACTORS IN DOMESTIC
VIOLENCE AGAINST THE ELDERLY**

Capítulo omitido por questões de originalidade de produção científica.

3.3 *Produção científica III:*

**ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO À
PESSOA IDOSA NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR**

**INTERVENTION STRATEGIES OF THE ELDERLY PROTECTION
NETWORK IN THE CONTEXT OF DOMESTIC VIOLENCE**

Capítulo omitido por questões de originalidade de produção científica.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A dissertação de mestrado apresentou reflexões quanto ao trabalho dos profissionais da rede de proteção, revelando a importância da articulação intersetorial, ações integradas e capacitações contínuas.

A produção I, composta por uma Revisão Integrativa da Literatura, discutiu as implicações da violência intrafamiliar na vida da pessoa idosa e as intervenções dos profissionais da rede de proteção. Quanto à pessoa idosa, a violência intrafamiliar compromete sua saúde física, emocional e social. No âmbito profissional, os resultados revelaram fragilidades na rede de proteção, reiterando a necessidade de articulação intersetorial, fluxos de atendimento e educação permanente.

Na produção II, de natureza quantitativa, observou-se que os profissionais com experiência prévia em intervenções de violência intrafamiliar contra a pessoa idosa apresentam maior percepção quanto os fatores de proteção. Identificou-se diferença estatística em relação à violência econômica e patrimonial entre os profissionais que já realizaram intervenções. Tais achados reforçam a importância da capacitação profissional e da articulação da rede de proteção, de modo a assegurar competência técnica frente às situações de violência intrafamiliar contra a pessoa idosa.

A produção III, de abordagem qualitativa, demonstrou a centralidade do termo “Violência” e sua articulação com os termos “Social”, “Apoio” e “Idoso”, indicando uma compreensão integrada do fenômeno. A análise revelou cinco dimensões interdependentes que se conectam em um ciclo contínuo de enfrentamento: conhecimento e percepção sobre violência intrafamiliar; percepção quanto às intervenções; estratégias de intervenção realizadas; necessidade de capacitação e qualificação; e divulgação e prevenção quanto à violência intrafamiliar. Esses resultados indicam que o enfrentamento à violência não deve ser fragmentado, exigindo a integração entre conhecimento, sensibilização, preparo técnico e avaliação crítica das ações.

Do ponto de vista prático, torna-se imprescindível o investimento em políticas públicas que fortaleçam a rede de proteção, ampliem campanhas educativas e garantam a formação contínua dos profissionais. É fundamental, ainda, fomentar ações intersetoriais que promovam o envelhecimento ativo e saudável, reduzindo vulnerabilidades e assegurando a proteção integral dos direitos da pessoa idosa.

Por fim, aponta-se como limitação deste estudo o tamanho da amostra e sua abrangência local. Recomenda-se que pesquisas futuras ampliem o escopo para diferentes regiões e incluam as perspectivas das próprias pessoas idosas e de seus núcleos familiares, permitindo uma visão ainda mais multidimensional do fenômeno.

REFERÊNCIAS

ALARCON, M. F. S. *et al.* Elder abuse: actions and suggestions by Primary Health Care professionals. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 74, n. suppl 2, e20200263, 2021a. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2020-0263>. Acesso em: 7 dez. 2025.

ALARCON, M. F. S. *et al.* Violence against the older adult: perceptions of the basic health care teams. **Texto & Contexto - Enfermagem**, Santa Catarina, v. 30, e20200099, 2021b. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-2020-0099>. Acesso em: 7 dez. 2025.

BALTES, P. B; BALTES, M. M. **Successful aging: perspectives from the behavioral sciences**. Cambridge University Press, New York, 1991.DOI: <https://doi.org/10.1017/CBO9780511665684>. Disponível em: <https://www.cambridge.org/core/books/successful-aging/9C9443F6E5D53BC108F6C9B4F775441D>. Acesso em: 05 ago. 2024.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. Tradução Luís Antero Reto, Augusto Pinheiro. São Paulo: Edições 70, 2016.

BARRETO, A. M. M. A. *et al.* Concepção de profissionais da saúde sobre violência contra idosos: revisão integrativa / Conception of health professionals on violence against the elderly: integrative review. **Brazilian Journal of Development**, [S. l.], v. 6, n. 7, p. 54165–54180, 2020. DOI: 10.34117/bjdv6n7-896. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/14307>. Acesso em: 24 ago. 2024.

BOLKAN, C.; TEASTER, P. B.; RAMSEY-KLAWSNIK, H. The context of elder maltreatment: an opportunity for prevention science. **Prevention Science: The Official Journal of the Society for Prevention Research**, [S. l.], v. 24, n. 5, p. 911–925, jul. 2023. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11121-022-01470-5>. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10161185/>. Acesso em: 15 ago. 2024.

BOMFIM, W. C.; CAMARGOS, M. C. S.; ZOCRATTO, K. B. F. Associação entre a violência intrafamiliar e as condições de saúde de idosos brasileiros. **Revista Baiana de Saúde Pública**, Salvador, v. 46, n. 3, p. 167-182, jul./set. 2022. DOI: 10.22278/2318-2660. Disponível em: <https://rbsp.associacao-violencia-intrafamiliar-saude-idosos-brasileiros>. Acesso em: 25 maio 2024.

BRASIL. Estatuto da Pessoa Idosa. **Lei nº 10.471**, de 1º de outubro de 2003.

BRASIL. Altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, para substituir, em toda a Lei, as expressões “idoso” e “idosos” pelas expressões “pessoa idosa” e “pessoas idosas”, respectivamente. **Lei nº 14.423**, de 22 de julho de 2022.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**. Brasília, DF: Presidência da República, 2020.

BRASIL. Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012. **Dispõe sobre diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos**. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 2012.

BRASIL. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. **Painel de Dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos**. Brasília, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/ondh/painel-de-dados/2024>. Acesso em: 02 fev. 2026.

BRASIL. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. **Painel de Dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos**. Brasília, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/ondh/painel-de-dados/2025>. Acesso em: 11 fev. 2026.

BRASIL. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. **Manual de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. É possível prevenir. É necessário superar**. Texto de Maria Cecília de Souza Minayo. Brasília, 2014. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/centrais-de-conteudo/pessoa-idosa/manual-de-enfrentamento-a-violencia-contr-a-pessoa-idosa>. Acesso em: 15 jul. 2024.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **Boletim Mulheres no Mercado de Trabalho**. Brasília: MTE, março 2025. Disponível em: https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/estatisticas-trabalho/publicacoes/boletim_mulheres_8m_20250307.pdf. Acesso em: 17 jan. 2026.

BRITO, K. M. dos S. M.; GROSSI, P. K.; GROSSI, M. L. Violência contra mulheres idosas em Manaus: Do silêncio ao enfrentamento. **Textos & Contextos**, Porto Alegre, v. 19, n. 1, e37325, 2020. Disponível em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/fass/article/view/37325>. Acesso em: 18 dez. 2025.

BÜLBÜL M. G.; ÜNLÜBAŞ, E. Examining the Relationship Between Daily Activity Levels and Elder Abuse and Neglect: Bringing Light on Elder Abuse. **Journal of Advanced Nursing**, [s. l.], v. 81, n. 12, p. 8738–8753, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/jan.17026>. Acesso em: 10 dez. 2025.

CECCON, R. F.; GARCIA-JR, C. A. S. Violência contra pessoas idosas dependentes no Brasil: um estudo multicêntrico. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação**, São Paulo, v. 28, e230511, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/interface.230511>. Acesso em: 10 dez. 2025.

CHANG, E.-S.; LEVY, B. R. High Prevalence of Elder Abuse During the COVID-19 Pandemic: Risk and Resilience Factors. **The American Journal of Geriatric Psychiatry**, [s. l.], v. 29, n. 11, p. 1152–1159, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jagp.2021.01.007>. Acesso em: 7 dez. 2025.

COLUSSI, E. L. *et al.* Perceptions of the elderly on aging and violence in intrafamily relationships. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 22, n. 4, p. e190034, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/1981-22562019022.190034>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbagg/a/9C3ycWCLPLbWvP8RSWhzVhm/?lang=pt#>. Acesso em: 24 ago. 2024.

CRUZ, M. H. S.; SANTOS, V. N. A violência na experiência de mulheres idosas nos centros de referências da assistência social. **Revista Internacional Interdisciplinar**, Florianópolis, v.18, n.1, p. 1-21, 2021. DOI: <https://doi.org/10.5007/1807-1384.2021.e76457>. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/interthesis/article/view/76457>. Acesso em: 24 ago. 2024.

DIAS, S. G. G. F. *et al.* Sentimentos vivenciados pela pessoa idosa em situação de violência. **Revista Baiana de Enfermagem**, Bahia, v. 37, 2023. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/enfermagem/article/view/46840>. Acesso em: 7 dez. 2025.

DOLL, J. *et al.* Multidimensionalidade do envelhecimento e interdisciplinaridade. In: Elizabete Viana de Freitas & Ligi Py (org.). **Tratado de Geriatria e Gerontologia**. 4. ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.

FALEIROS, V. de P. A estruturação do idadismo contra a pessoa idosa. **Oikos: Família e Sociedade em Debate**, Viçosa, v. 34, n. 2, p. 01-10, 2023. DOI: <https://doi.org/10.31423/oikos.v34i2.15332>. Disponível em: <https://periodicos.ufv.br/oikos/article/view/15332>. Acesso em: 16 ago. 2024.

GOES, A. L.de; CEZARIO, K. G. Atuação da equipe de saúde da família na atenção ao idoso em situação de violência: revisão integrativa. **Revista Arquivos de Ciência da Saúde**, [S. l.], v.24, n.2, p.100-105, 2017. Disponível em: https://repositorio-racs.famerp.br/racs_ol/vol-24-2/index.html. Acesso em: 12 jun. 2024.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **População por idade e sexo (Pessoas Idosas - 60 anos ou mais de idade)**, 2022. Disponível em: <https://censo2022.ibge.gov.br>. Acesso em: 15 jul. 2024.

JAMSHIDIMANESH, M.; HOSSEINI, R. S.; PEZARO, S. Exploring the experiences and coping strategies of older women encountering domestic violence and abuse: a qualitative study. **BMC Geriatrics**, [s. l.], v. 25, n. 1, p. 252, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12877-025-05889-7>. Acesso em: 08 dez. 2025.

KRUG, E.G. *et al.* **World report on violence and health**. Geneva: World Health Organization, 2002. Disponível em: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/42495/9241545615_eng.pdf?sequence=1. Acesso em: 10 ago. 2024.

LIMA, V. M. D. F. *et al.* Characterization and completeness of notification sheet of violence against the older adults in Niterói-RJ, 2011-2020. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, Brasília, v. 32, n. 1, e2022451, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S2237-96222023000100024>. Acesso em: 10 dez. 2025.

LIU, P.; CHILATRA, J. A. H.; PHELAN, A. Examining nurses' role in Adult Protective Services related to safeguarding older people. **Journal of Advanced Nursing**, [s. l.], v. 77, n. 5, p. 2481–2497, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/jan.14792>. Acesso em: 08 dez. 2025.

MELEIRO, M. L. de. A. P.; PEREIRA, C. D. M. M. A notificação compulsória de violência contra a pessoa idosa em Manaus/Amazonas/Brasil. **Revista Internacional Consinter de Direito**, Paraná, p. 325, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.19135/revista.consinter.00017.14>. Acesso em: 10 dez. 2025.

MELEIRO, M. L. de A. P. *et al.* Os desafios da rede de proteção no enfrentamento à violência contra a pessoa idosa em Manaus, Amazonas, Brasil. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, Rio de Janeiro, v. 24, n. 6, e210133, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1981-22562020024.210133>. Acesso em: 10 dez. 2025.

MELNYK B. M.; FINEOUT-OVERHOLT E. **Evidence-based practice in nursing and healthcare: a guide to best practice**. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2011.

MENDES, K. D. S.; SILVEIRA, R. C. C. P.; GALVÃO, C. M. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Texto & contexto-enfermagem**, Santa Catarina, v. 17, p. 758-764, 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tce/a/XzFkq6tjWs4wHNqNjKJLkXQ/?format=pdf&lang=p>. Acesso em: 10 dez. 2025.

MINAYO, M. C. de S. Violência e saúde. Rio de Janeiro: **Editora FIOCRUZ**, 2006. (Coleção Temas em Saúde). 132 p. ISBN 978-85-7541-380-7. Disponível em: <https://static.scielo.org/scielobooks/y9sxc/pdf/minayo-9788575413807.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2024.

MINAYO, M. C. de S. Visão antropológica do envelhecimento humano. In: **SESC. Velhices: reflexões contemporâneas**. São Paulo: Sesc/PUC-SP, 2006.

MINAYO, M. C. de S. Violência contra a pessoa idosa: castigo do corpo e mortificação do eu. In: FREITAS, E. V.; PY, L. (org.). **Tratado de geriatria e gerontologia**. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.

MORENO, L. de D.; ALVES, R. M.; MACHADO, A. K. C. Família e violência contra a pessoa idosa: Valores invertidos ou despreparo familiar? **Brazilian Journal of Development**, [S. l.], v. 6, n. 9, p. 70096–70106, 2020. DOI: 10.34117/bjdv6n9-454. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/16901>. Acesso em: 15 jun. 2024.

MORILLA, J. L.; MANSO, M. E. G. A violência contra a mulher idosa no Brasil e os fatores relacionados ao tema: uma revisão integrativa. **VITTALLE - Revista de Ciências da Saúde**, [S. l.], v. 33, n. 2, p. 66–82, 2021. DOI: 10.14295/vittalle.v33i2.12328. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/vittalle/article/view/12328>. Acesso em: 12 jun. 2024.

MOTAMEDI, A.; LUDVIGSSON, M.; SIMMONS, J. Factors associated with healthcare professionals talking to older patients about being subjected to abuse. **Journal of Elder Abuse & Neglect**, v. 34, n. 1, p. 20–37, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/08946566.2021.2014378>. Acesso em: 10 dez. 2025.

OLIVEIRA, M. A.; CEBALLOS, A. G. Violência contra a pessoa idosa: percepções de profissionais da saúde. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 14, e326111422645, 2022. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i14.32645> (doi.org in Bing). Disponível em: <https://rsdjournal.org/rsd/article/view/32645/27707>. Acesso em: 17 jan. 2026.

OLIVEIRA, K. S. M. *et al.* Violência contra idosos: concepções dos profissionais de enfermagem acerca da detecção e prevenção. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 39, e57462, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2018.57462>. Acesso em: 5 fev. 2026.

PĂROȘANU, A.; MARSHALL, C. Responding restoratively to elder harm: lessons from a pilot scheme in Aotearoa New Zealand. **Journal of Elder Abuse & Neglect**, [s. l.], v. 35, n. 4–5, p. 212–227, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/08946566.2023.2286486>. Acesso em: 10 dez. 2025.

PEREIRA, J. B. *et al.* Marcas da violência entre pessoas idosas. **Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online**, Rio de Janeiro, v. 12, p. 928–933, 2021. DOI: 10.9789/2175-5361.rpcfo.v12.7991. Disponível em: <https://seer.unirio.br/cuidadofundamental/article/view/7991>. Acesso em: 25 mai. 2024.

PIPPI, G. de A. *et al.* Caracterização dos casos de violência contra idosos no município de Santa Maria. **Estudos Interdisciplinares sobre o Envelhecimento**, [S. l.], v. 25, n. 3, 2020. DOI: 10.22456/2316-2171.73381. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/RevEnvelhecer/article/view/73381>. Acesso em: 12 mai. 2024.

RABELO, D. F. Os idosos e as relações familiares. In: FREITAS, E. V.; PY, L. (org.). **Tratado de geriatria e gerontologia**. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016

RIBEIRO, D. A. T. *et al.* Vulnerability, family violence and institutionalization: narratives for elderly and professionals in social welcome center. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, Porto Alegre, v. 42, p. e20200259, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2021.20200259>. Acesso em: 10 dez. 2025.

RIBEIRO, M. de N. de S. *et al.* Violência intrafamiliar contra a pessoa idosa em área urbana com suporte de proteção social e de saúde. **Estudos Interdisciplinares sobre o Envelhecimento**, [S. l.], v. 25, n. 3, 2021. DOI: 10.22456/2316-2171.102870. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/RevEnvelhecer/article/view/102870>. Acesso em: 25 mai. 2024.

ROCHA, E. N. *et al.* Estrutura representacional de profissionais da estratégia de saúde da família sobre violência intrafamiliar contra idosos [Family health strategy personnel's representational structures regarding domestic violence against older adults]. **Revista Enfermagem UERJ**, Rio de Janeiro, v. 23, n. 2, p. 178–184, 2015. DOI: 10.12957/reuerj.2015.7450. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/enfermagemuerj/article/view/7450>. Acesso em: 14 jun. 2024.

ROSEN, T. *et al.* Identifying and initiating intervention for elder abuse and neglect in the emergency department. **Clinics in Geriatric Medicine**, [S.l.], v. 34, n. 3, p. 435-451, ago. 2018. DOI: 10.1016/j.cger.2018.04.007. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6057151/pdf/nihms961991.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2024.

SALES, D. S. *et al.* A violência contra o idoso na visão do agente comunitário de saúde. **Estudos Interdisciplinares sobre o Envelhecimento**, [S. l.], v. 19, n. 1, 2014. DOI: 10.22456/2316-2171.36910. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/RevEnvelhecer/article/view/36910>. Acesso em: 12 jun. 2024.

SANTA-CRUZ-ESPINOZA, H.; SAONA-CARRIL, K. L.; JARA-BARRENA, M. M. Relação entre Sintomas Psicopatológicos e Funcionamento Familiar em Idosos Vítimas de Violência Familiar. **Revista Cubana Enfermagem**, Ciudad de la Habana, v.38, n. 1, jan./mar. 2022. Disponível em: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192022000100005&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 25 mai. 2024.

SANTOS, A. C. D. *et al.* Risco de violência e apoio social em idosos: estudo transversal. **Acta Paulista de Enfermagem**, São Paulo, v. 35, p. eAPE039006334, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.37689/acta-ape/2022AO006334>. Acesso em: 10 dez. 2025.

SANTOS, M. A. B. dos *et al.* Fatores associados à violência contra o idoso: uma revisão sistemática da literatura. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 25, n. 6, p. 2153–2175, jun. 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232020256.25112018>. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/csc/a/MpcwN3kZjqZnK9FQXYc6T6j/#>. Acesso em: 24 ago. 2024.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL. **Enfrentamento da violência contra pessoa idosa na saúde: orientações para gestores e profissionais de saúde**. Porto Alegre: Secretaria de Estado da Saúde do Rio Grande do Sul, 2016.

SHIMBO, A. Y.; LABRONICI, L. M.; MANTOVANI, M. DE F. Reconhecimento da violência intrafamiliar contra idoso pela equipe da Estratégia de Saúde da Família. **Escola Anna Nery**, Rio de Janeiro, v.15, n.3, p. 506-510, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1414-81452011000300009>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ean/a/z9R3gR7p9YFxFxJcXqfzPcDvv/#>. Acesso em: 12 jun. 2024.

SILVA, S. P. C. E. *et al.* Violência na velhice: representações sociais elaboradas por pessoas idosas. **Escola Anna Nery**, v. 27, e20220169, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2022-0169pt>. Acesso em: 30 jul. 2024.

SOBRAL, J. P.; MARINHO, M. L.; ROCHA, B. M. da. Desafios enfrentados pelo enfermeiro no atendimento à pessoa idosa vítima de violência doméstica: uma abordagem qualitativa. **Cogitare Enfermagem**, v. 28, e86295, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/ce.v28i0.86295>. Acesso em: 10 jan. 2026.

SOUZA, E. R. DE.; MINAYO, M. C. DE S. Inserção do tema violência contra a pessoa idosa nas políticas públicas de atenção à saúde no Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 15, n. 6, p. 2659–2668, set. 2010. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232010000600002>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/cLxGxrPVVmXkwqJqcjJ4F3s/#>. Acesso em: 27 mai. 2024.

SPRENG, R. N.; KARLAWISH, J.; MARSON, D. C. Cognitive, social, and neural determinants of diminished decision-making and financial exploitation risk in aging and dementia: a review and new model. **Journal of Elder Abuse & Neglect**, [S.l.], v. 28, n. 4, p. 320–344, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1080/08946566.2016.1237918>. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8154217/pdf/nihms-890149.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2024.

SWIECH, L. M.; RENK, V. E. The education of health professionals in coping with violence against elderly women. **Seven Editora**, [S. l.], 2023. Disponível em: <https://sevenpublicacoes.com.br/editora/article/view/2125>. Acesso em: 24 ago. 2024.

VALE, M. S. do. *et al.* Mediação de Conflitos de Violência Intrafamiliar Contra Pessoas Idosas: uma proposta não jurídica / Proposed Methodology of Work for The Mediation of Violence Against Elderly People Conflicts: a non-legal proposition. **Textos & Contextos**, Porto Alegre, v. 14, n. 1, p. 104–114, 2015. DOI: 10.15448/1677-9509.2015.1.18168. Disponível em:

<https://revistaseletronicas.pucrs.br/fass/article/view/18168>. Acesso em: 24 ago. 2024.

VASCONCELOS, E. C. F. R de, *et al.* “Nenhuma Pessoa Idosa Merece Passar por Isso”: Compreensão da Violência para Mulheres Gerontes. **Enfermería Actual en Costa Rica**, Costa Rica, n. 46, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.15517/enferm.actual.cr.i46.53042>. Acesso em: 7 dez. 2025.

VERNASQUE, J. R. S. *et al.* Efeito de uma intervenção educativa para universitários sobre violência contra a pessoa idosa por meio da gamificação: ensaio clínico não randomizado. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, São Paulo, v. 33, e4663, 2025. DOI: 10.1590/1518-8345.7874.4663. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1518-8345.0000.4742>. Acesso em: 12 dez. 2025.

WANDERBROOCKE, A. C. N. de S.; MORÉ, C. L. O. O. Abordagem profissional da violência familiar contra o idoso em uma unidade básica de saúde. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 29, n. 12, p. 2513–2522, dez. 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00174112>. Acesso em: 2 fev. 2026.

WHITTEMORE, Robin; KNAFL, Kathleen. The integrative review: updated methodology. **Journal of Advanced Nursing**, v. 52, n. 5, p. 546-553, 2 nov. 2005. DOI: Wiley.<http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x>. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x>.

YAN, E. *et al.* Strategies to build more effective interventions for elder abuse: a focus group study of nursing and social work professionals in Hong Kong. **BMC Geriatrics**, [s. l.], v. 22, n. 1, p. 978, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12877-022-03682-4>. Acesso em: 12 dez. 2025.

YON, Y. *et al.* Elder abuse prevalence in community settings: a systematic review and meta-analysis. **The Lancet Global Health**, v. 5, n. 2, p. 147-156, 2017. DOI: 10.1016/S2214-109X(17)30006-2. Disponível em: [https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X\(17\)30006-2/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(17)30006-2/fulltext). Acesso em: 15 ago. 2024.

APÊNDICES

Apêndice A. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido



**UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO
INSTITUTO DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ENVELHECIMENTO HUMANO**

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

Venho, respeitosamente convidá-lo(a) para participar da pesquisa intitulada “Violência intrafamiliar contra a pessoa idosa: percepção e estratégias de intervenção”, que estou desenvolvendo com o objetivo de obter o título de mestra em Envelhecimento Humano, pelo Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano da Universidade de Passo Fundo, sob orientação da Profa. Dra. Graciela de Brum Palmeiras.

O objetivo geral do estudo é verificar a percepção dos profissionais que compõem a rede de proteção e as estratégias de intervenção utilizadas nas situações de suspeita ou confirmação de violência intrafamiliar contra a pessoa idosa.

A sua participação na pesquisa será por meio do preenchimento do questionário semiestruturado por meio da ferramenta *Google Forms*. O questionário está relacionado aos dados sociodemográficos e específicos para responder aos objetivos do estudo, com perguntas de múltipla escolha e perguntas abertas, possibilitando que você discorra livremente sobre suas percepções referentes à temática.

Esclarecemos que a sua participação não é obrigatória e, portanto, poderá desistir a qualquer momento, interrompendo o preenchimento. Além disso, garantimos que receberá esclarecimentos sobre qualquer dúvida relacionada à pesquisa e poderá ter acesso aos seus dados em qualquer etapa do estudo. As informações não envolverão a identificação do nome dos participantes. Tais dados serão utilizados apenas para fins acadêmicos, sendo garantido o sigilo das informações.

A sua participação nesta pesquisa não traz complicações legais. Em relação aos riscos para os participantes deste estudo, aponta-se que toda pesquisa com seres humanos envolve algum tipo de risco, podendo ser danos imediatos ou posteriores, tanto no plano individual como no coletivo. Não será realizado nenhum tipo de procedimento invasivo, nem coleta de material

biológico ou experimentos com seres humanos. Sendo assim, caso for identificado algum sinal de desconforto psicológico referente à participação na pesquisa, pedimos que nos avise. Caso ocorra, as pesquisadoras comprometem-se em orientar e encaminhar para os profissionais especializados na área, pela rede pública. Destaca-se que para amenizar ou suprimir esses riscos, as questões poderão ser respondidas ou não, sem prejuízo ao participante. Além disso, lembramos que você não terá qualquer despesa para participar da presente pesquisa e não receberá pagamento pela participação no estudo. Caso ocorra eventual dano comprovadamente decorrente da sua participação na pesquisa, o (a) senhor (a) tem o direito de buscar indenização.

Quanto aos benefícios, se justifica o tema pela relevância científica e social, e pela busca de estratégias de intervenção que poderão auxiliar na prevenção ou redução da incidência de violência intrafamiliar contra a pessoa idosa, bem como na criação de políticas públicas.

Caso tenha dúvida sobre a pesquisa e seus procedimentos, o (a) senhor (a) pode entrar em contato com a mestrande Karine Paludo, pelo telefone (54) 9 9924-4896, no e-mail 120617@upf.br, ou com a orientadora a Profa. Dra. Graciela de Brum Palmeiras, pelo telefone (54) 99121-1402, no e-mail graciela@upf.br, de segunda à sexta, nos horários 8h às 11h35min e das 14h00min às 17h35min, ou também pode consultar o Comitê de Ética em Pesquisa da UPF, pelo telefone (54) 3316-8157, no horário das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h30min, de segunda a sexta-feira. O comitê está localizado no Campus I da Universidade de Passo Fundo, na BR 285, Km 292, Centro Administrativo, Bairro São José, Passo Fundo/RS. O Comitê de Ética em Pesquisa exerce papel consultivo e, em especial, educativo, para assegurar a formação continuada dos pesquisadores e promover a discussão dos aspectos éticos das pesquisas em seres humanos na comunidade.

Dessa forma, se você concorda em participar da pesquisa como consta nas explicações e orientações registradas neste termo, pedimos que assinale a opção correspondente para que você tenha acesso ao questionário.

Como forma de REGISTRO do presente consentimento, sugerimos que você faça uma cópia para si (pode ser realizada via screening de tela).

Desde já, agradecemos a sua participação e colaboração!

Passo Fundo, novembro de 2024.

Mestranda Karine Paludo.

Profa. Dra. Graciela de Brum Palmeiras.

Nesses termos, com base nas considerações apresentadas sobre a pesquisa:

- ☐ Eu concordo em participar da pesquisa
- ☐ Não concordo em participar da pesquisa

Apêndice B. Questionário Semiestruturado



UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO
INSTITUTO DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ENVELHECIMENTO HUMANO

QUESTIONÁRIO SEMIESTRUTURADO PARA PROFISSIONAIS DA REDE DE PROTEÇÃO

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Qual órgão da rede de proteção você trabalha?

- ☐ Sistema Único de Saúde – SUS
- ☐ Sistema Único de Assistência Social – SUAS
- ☐ Poder Judiciário
- ☐ Delegacia de Polícia Civil
- ☐ Brigada Militar

Nome: _____

E-mail: _____

Idade: _____

Gênero autodeclarado: () Masculino () Feminino () Não binário () outro _____

Estado Civil: () Solteiro(a) () Casado(a) () União estável () Divorciado(a)

() Divorciado(a) () Separado(a) () Viúvo(a)

2) ASPECTOS PROFISSIONAIS

Cargo/função: _____

Escolaridade: () Ensino médio () Curso técnico () Curso superior incompleto

() Curso superior completo () Pós-Graduação - latu sensu - especialização

() Pós-Graduação – stricto sensu - mestrado/doutorado

Curso superior/graduação em: _____

Tempo de atuação no local de trabalho: () de 1 mês a 03 anos () de 04 anos a 06 anos () 07 anos a 10 anos () mais de 10 anos

Carga horária de trabalho semanal: _____

Possui mais de um emprego? se a resposta for sim, descreva o local e carga horária:

3) ASPECTOS DE RENDA

Qual sua renda mensal, aproximadamente:

- ☐ Até um salário mínimo (R\$ 1.412,00)
- ☐ De 01 a 03 salário mínimos (de R\$ 1.412,00 até R\$ 4.236,00)
- ☐ De 03 a 06 salário mínimos (de R\$ 4.236,00 até R\$ 8.472,00)
- ☐ Mais de 06 salários mínimos.

Qual sua renda FAMILIAR, aproximadamente:

- ☐ Até um salário mínimo (R\$ 1.412,00)
- ☐ De 01 a 03 salário mínimos (de R\$ 1.412,00 até R\$ 4.236,00)
- ☐ De 03 a 06 salário mínimos (de R\$ 4.236,00 até R\$ 8.472,00)
- ☐ Mais de 06 salários mínimos.

NESTE MOMENTO VOCÊ PASSARÁ A RESPONDER QUESTÕES QUANTO AO TEMA VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR CONTRA A PESSOA IDOSA.

- 1) Como chega uma denúncia de violência intrafamiliar contra a pessoa idosa junto ao seu local de trabalho? Pode assinalar mais de uma opção.
 - ☐ Família
 - ☐ Telefone
 - ☐ E-mail
 - ☐ disque100
 - ☐ Vizinho
 - ☐ Não sei
- 2) O que é para você violência intrafamiliar contra a pessoa idosa?
- 3) Quais os tipos de violência intrafamiliar contra a pessoa idosa identificadas com maior prevalência de atendimento no seu ambiente de trabalho? Pode assinalar mais de uma opção.
 - ☐ Violência física
 - ☐ Violência psicológica
 - ☐ Violência financeira/econômica
 - ☐ Violência sexual
 - ☐ Negligência
 - ☐ Abandono

- 4) A partir da resposta anterior, descreva quais suas percepções sobre violência intrafamiliar contra a pessoa idosa nos casos de suspeita ou confirmação atendidas no seu local de trabalho?
- 5) O que você identifica como fator de risco para ocorrer a violência intrafamiliar contra a pessoa idosa. Para cada opção abaixo assinale o item que você considera de maior relevância:

Relações familiares fragilizadas:

- ☐ Muito pouco
- ☐ Pouco
- ☐ Mais ou menos
- ☐ Muito
- ☐ MUITÍSSIMO

Idade avançada:

- ☐ Muito pouco
- ☐ Pouco
- ☐ Mais ou menos
- ☐ Muito
- ☐ MUITÍSSIMO

Sexo:

- ☐ Muito pouco
- ☐ Pouco
- ☐ Mais ou menos
- ☐ Muito
- ☐ MUITÍSSIMO

Estado civil:

- ☐ Muito pouco
- ☐ Pouco
- ☐ Mais ou menos
- ☐ Muito
- ☐ MUITÍSSIMO

Nível de renda:

- ☐ Muito pouco
- ☐ Pouco
- ☐ Mais ou menos
- ☐ Muito
- ☐ MUITÍSSIMO

Nível de escolaridade:

- ☐ Muito pouco
- ☐ Pouco
- ☐ Mais ou menos
- ☐ Muito
- ☐ MUITÍSSIMO

Falta de suporte social:

- ☐ Muito pouco
- ☐ Pouco
- ☐ Mais ou menos
- ☐ Muito
- ☐ MUITÍSSIMO

Transtornos mentais e depressão:

- ☐ Muito pouco
- ☐ Pouco
- ☐ Mais ou menos
- ☐ Muito
- ☐ MUITÍSSIMO

Abuso de álcool e/ou drogas por familiares:

- ☐ Muito pouco
- ☐ Pouco
- ☐ Mais ou menos
- ☐ Muito
- ☐ MUITÍSSIMO

Dependência da pessoa idosa para atividades da vida diária:

- ☐ Muito pouco
- ☐ Pouco
- ☐ Mais ou menos
- ☐ Muito
- ☐ MUITÍSSIMO

Doenças crônicas da pessoa idosa:

- ☐ Muito pouco
- ☐ Pouco
- ☐ Mais ou menos
- ☐ Muito
- ☐ MUITÍSSIMO

Histórico de violência:

- ☐ Muito pouco
- ☐ Pouco
- ☐ Mais ou menos
- ☐ Muito
- ☐ MUITÍSSIMO

Outras. Quais: _____

- 6) O que você identifica como fatores de proteção para não ocorrer a violência intrafamiliar contra a pessoa idosa? Assinale a opção que você considera de maior relevância.

Vínculos familiares fortalecidos:

- ☐ Muito pouco
- ☐ Pouco
- ☐ Mais ou menos
- ☐ Muito
- ☐ MUITÍSSIMO

Boas condições de saúde:

- ☐ Muito pouco
- ☐ Pouco
- ☐ Mais ou menos
- ☐ Muito
- ☐ MUITÍSSIMO

Residir Sozinho (a):

- ☐ Muito pouco
- ☐ Pouco
- ☐ Mais ou menos
- ☐ Muito
- ☐ MUITÍSSIMO

Residir com familiares:

- ☐ Muito pouco
- ☐ Pouco
- ☐ Mais ou menos
- ☐ Muito
- ☐ MUITÍSSIMO

Nível de renda:

- ☐ Muito pouco
- ☐ Pouco
- ☐ Mais ou menos
- ☐ Muito
- ☐ MUITÍSSIMO

Independência para atividades da vida diária:

- ☐ Muito pouco
- ☐ Pouco
- ☐ Mais ou menos
- ☐ Muito
- ☐ MUITÍSSIMO

Nível de escolaridade:

- ☐ Muito pouco
- ☐ Pouco
- ☐ Mais ou menos
- ☐ Muito
- ☐ Muitíssimo

Atividades coletivas para pessoas idosas:

- ☐ Muito pouco
- ☐ Pouco
- ☐ Mais ou menos
- ☐ Muito
- ☐ Muitíssimo

Campanhas de conscientização contínuas:

- ☐ Muito pouco
- ☐ Pouco
- ☐ Mais ou menos
- ☐ Muito
- ☐ Muitíssimo

Outras. Quais: _____

- 7) Você já entrevistou em alguma situação de suspeita ou confirmação de violência intrafamiliar contra a pessoa idosa? se sim, como foi sua intervenção?
- 8) Como você acredita que deve ser a intervenção/encaminhamento conforme seu cargo/função? Explique
- 9) Você se considera uma pessoa capaz de realizar intervenção e encaminhamento nos casos de suspeita ou confirmação de violência intrafamiliar contra a pessoa idosa? se sim, explique. Se a resposta for não, explique qual profissional você considera habilitado.
- 10) Quais estratégias de intervenção você utiliza nos casos de suspeita ou confirmação de violência intrafamiliar contra pessoa idosa?
- 11) Quais os encaminhamentos realizados pelo órgão nos casos de suspeita ou confirmação de violência intrafamiliar contra a pessoa idosa?
- 12) Quais suas percepções quanto as intervenções dos profissionais da rede de atendimento nos casos de violência intrafamiliar contra a pessoa idosa?
- 13) Como você observa a necessidade de fluxos de atendimento, encaminhamentos e capacitações contínuas?

- 14) Quais suas considerações referente a violência intrafamiliar, como ela se estabelece nas relações familiares e como os órgãos deveriam trabalhar no enfrentamento?
- 15) Você considera que este tema deveria ser abordado em outros espaços institucionais? Se sim, quais?
- 16) Fique à vontade para trazer suas considerações sobre o tema e como se sentiu respondendo este questionário.

Muito obrigada pela sua participação!

Tenho certeza que sua contribuição foi de grande relevância para a realização desta pesquisa.

Fico a disposição para esclarecimentos e dúvidas. Mestranda

Karine Paludo

Apêndice C. Carta de Anuência Fórum



UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO
INSTITUTO DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ENVELHECIMENTO HUMANO

CARTA DE ANUÊNCIA

Passo Fundo, 09 de outubro de 2024.

Ilustríssimo Sr.

Dr. Juiz de direito da Vara Judicial da Comarca de Ronda Alta

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo, solicitamos a Vossa Senhoria autorização para o desenvolvimento de uma pesquisa acadêmica que pretendemos realizar com os profissionais do sistema de proteção que realizam atendimento a pessoa idosa.

O estudo é intitulado **“Violência intrafamiliar contra a pessoa idosa: percepção e estratégias de intervenção”**, trata-se do projeto de pesquisa que estou desenvolvendo com o objetivo de obter o título de mestra em Envelhecimento Humano, pelo Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano da Universidade de Passo Fundo, sob orientação da Profa. Dra. Graciela de Brum Palmeiras.

O objetivo geral do estudo será verificar a percepção dos profissionais que compõem o sistema de proteção e as estratégias de intervenção utilizadas nas situações de suspeita ou confirmação de violência intrafamiliar contra a pessoa idosa.

O estudo será de abordagem qualitativa, de caráter descritivo, exploratório e de cunho transversal. E para contemplar os objetivos desta pesquisa será enviado por e-mail um questionário semiestruturado desenvolvido pela ferramenta *Google Forms*, relacionado aos dados sociodemográficos e específicos, com perguntas de múltipla escolha e perguntas abertas, possibilitando que o profissional discorra livremente sobre suas percepções referentes a temática.

Reiteramos que a pesquisa contempla a Resolução 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2013) e a Lei Geral de Proteção de

Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709/2018 e que dar-se-á início somente após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Passo Fundo.

Atenciosamente,



Karine Paludo

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano
Universidade de Passo Fundo

Apêndice D. Carta de Anuência Delegacia de Polícia Civil



UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO
INSTITUTO DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ENVELHECIMENTO HUMANO

CARTA DE ANUÊNCIA

Passo Fundo, 09 de outubro de 2024.

Ilustríssimo Sr.

Dr. Delegado de Polícia Civil do Município de Ronda Alta

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo, solicitamos a Vossa Senhoria autorização para o desenvolvimento de uma pesquisa acadêmica que pretendemos realizar com os profissionais do sistema de proteção que realizam atendimento a pessoa idosa.

O estudo é intitulado **“Violência intrafamiliar contra a pessoa idosa: percepção e estratégias de intervenção”**, trata-se do projeto de pesquisa que estou desenvolvendo com o objetivo de obter o título de mestra em Envelhecimento Humano, pelo Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano da Universidade de Passo Fundo, sob orientação da Profa. Dra. Graciela de Brum Palmeiras.

O objetivo geral do estudo será verificar a percepção dos profissionais que compõem o sistema de proteção e as estratégias de intervenção utilizadas nas situações de suspeita ou confirmação de violência intrafamiliar contra a pessoa idosa.

O estudo será de abordagem qualitativa, de caráter descritivo, exploratório e de cunho transversal. E para contemplar os objetivos desta pesquisa será enviado por e-mail um questionário semiestruturado desenvolvido pela ferramenta *Google Forms*, relacionado aos dados sociodemográficos e específicos, com perguntas de múltipla escolha e perguntas abertas, possibilitando que o profissional discorra livremente sobre suas percepções referentes a temática.

Reiteramos que a pesquisa contempla a Resolução 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2013) e a Lei Geral de Proteção de

Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709/2018 e que dar-se-á início somente após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Passo Fundo.

Atenciosamente,



Karine Paludo

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano
Universidade de Passo Fundo

Apêndice E. Carta de Anuência Prefeitura Municipal de Três Palmeiras



UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO
INSTITUTO DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ENVELHECIMENTO HUMANO

CARTA DE ANUÊNCIA

Passo Fundo, 09 de outubro de 2024.

Ilustríssima Sr.

Prefeito Municipal de Três Palmeiras/RS

Claumir Cesar de Oliveira

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo, solicitamos a Vossa Senhoria autorização para o desenvolvimento de uma pesquisa acadêmica que pretendemos realizar com os profissionais do sistema de proteção que realizam atendimento à pessoa idosa.

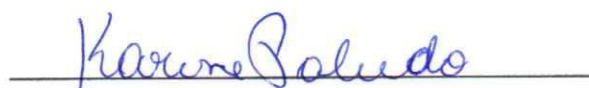
O estudo é intitulado **“Violência intrafamiliar contra a pessoa idosa: percepção e estratégias de intervenção”**, trata-se do projeto de pesquisa que estou desenvolvendo com o objetivo de obter o título de mestra em Envelhecimento Humano, pelo Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano da Universidade de Passo Fundo, sob orientação da Profa. Dra. Graciela de Brum Palmeiras.

O objetivo geral do estudo será verificar a percepção dos profissionais que compõem o sistema de proteção e as estratégias de intervenção utilizadas nas situações de suspeita ou confirmação de violência intrafamiliar contra a pessoa idosa.

O estudo será de abordagem qualitativa, de caráter descritivo, exploratório e de cunho transversal. E para contemplar os objetivos desta pesquisa será enviado por e-mail um questionário semiestruturado desenvolvido pela ferramenta *Google Forms*, relacionado aos dados sociodemográficos e específicos, com perguntas de múltipla escolha e perguntas abertas, possibilitando que o profissional discorra livremente sobre suas percepções referentes a temática.

Reiteramos que a pesquisa contempla a Resolução 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2013) e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709/2018 e que dar-se-á início somente após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Passo Fundo.

Atenciosamente,



Karine Paludo

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano
Universidade de Passo Fundo

ANEXOS

Anexo A. Parecer Consubstanciado do CEP

UNIVERSIDADE DE PASSO
FUNDO / PRÓREITORIA
ACADÊMICA-PROACAD/UPF



PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR CONTRA A PESSOA IDOSA: PERCEPÇÃO E ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO

Pesquisador: Karine Paludo

Área Temática:

Versão: 1

CAAE: 84635324.8.0000.5342

Instituição Proponente: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 7.250.207

Apresentação do Projeto:

A violência contra a pessoa idosa se caracteriza como um grave problema social e de saúde pública, bem como, traz inúmeras consequências para a saúde física, mental e qualidade de vida das vítimas. Pessoas longevas podem ser vítimas das mais distintas formas de violência, como violência física, psicológica, negligência, abandono, sexual e financeira. A complexidade da violência intrafamiliar é intensificada pelo fato de que, em muitos casos, os agressores são membros da própria família, o que leva à percepção do problema como uma „questão familiar“, tanto pelas vítimas quanto pelos profissionais, dificultando denúncias, encaminhamentos e intervenções adequadas. Esse contexto exige atenção especial dos profissionais do sistema de proteção, pois precisam estar capacitados para identificar e intervir de forma eficaz. Desta maneira, o presente estudo tem por objetivo geral verificar a percepção dos profissionais que compõem o sistema de proteção e as estratégias de intervenção utilizadas nas situações de suspeita ou confirmação de violência intrafamiliar contra a pessoa idosa. Trata-se de um estudo de caráter descritivo, exploratório, de abordagem qualitativa e de cunho transversal. A coleta de dados se dará através de um questionário semiestruturado, desenvolvido pela ferramenta Google

Endereço: BR 285- Km 292 Campus I - 4º andar Centro Administrativo

Bairro: São José

CEP: 99.052-900

UF: RS

Município: PASSO FUNDO

Telefone: (54)3316-8157

E-mail: cep@upf.br

UNIVERSIDADE DE PASSO
FUNDO / PRÓREITORIA
ACADÊMICA-PROACAD/UPF



Continuação do Parecer: 7.250.207

Forms, relacionado aos dados sociodemográficos e específicos, com perguntas de múltipla escolha e perguntas abertas, possibilitando que o profissional discorra livremente sobre suas percepções referentes à temática. A pesquisa atende a Resolução 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709/2018. Para a análise e categorização dos dados será utilizado o software NVivo

10, os dados serão tratados por meio da técnica de análise de conteúdo de Bardin. O estudo apresenta relevância científica e social, e seus resultados poderão contribuir na busca de estratégias de intervenção, auxiliando na prevenção ou redução da incidência de violência intrafamiliar contra a pessoa idosa, bem como na criação de políticas públicas.

Objetivo da Pesquisa:

Objetivo Primário:

Verificar a percepção dos profissionais que compõem o sistema de proteção e as estratégias de intervenção utilizadas nas situações de suspeita ou confirmação de violência intrafamiliar contra a pessoa idosa.

Objetivo Secundário:

Conhecer o perfil dos profissionais do sistema de proteção que realizam o atendimento à pessoa idosa. Conhecer a percepção dos profissionais do sistema de proteção em relação aos tipos de violência contra a pessoa idosa. Identificar os fatores de risco e de proteção apontados pelos profissionais do sistema de proteção. Verificar as estratégias de intervenção utilizadas nas situações de suspeita ou confirmação de violência intrafamiliar contra a pessoa idosa.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Riscos:

Quanto aos riscos para os participantes deste estudo, aponta-se que toda pesquisa com seres humanos envolve algum tipo de risco, podendo ser danos imediatos ou posteriores, tanto no plano individual como no coletivo. Destaca-se que a presente pesquisa envolverá, exclusivamente, a aplicação de questionário semiestruturado por meio do formulário Google Forms, com dados sociodemográficos e perguntas relacionadas à temática do estudo. Não será realizado nenhum tipo de procedimento invasivo, nem coleta de material

Endereço: BR 285- Km 292 Campus I - 4º andar Centro Administrativo

Bairro: São José **CEP:** 99.052-900

UF: RS **Município:** PASSO FUNDO

Telefone: (54)3316-8157

E-mail: cep@upf.br

UNIVERSIDADE DE PASSO
FUNDO / PRÓREITORIA
ACADÊMICA-PROACAD/UPF



Continuação do Parecer: 7.250.207

biológico ou experimentos com seres humanos. No entanto, por se tratar de uma temática complexa, caso algum participante sinta algum desconforto psicológico, poderá optar em responder ou interromper o preenchimento do questionário, neste caso, se necessário, as pesquisadoras se comprometem a encaminhar o participante para atendimento especializado pela rede pública de saúde.

Benefícios:

Quanto aos benefícios, se justifica o tema pela relevância científica e social, e pela busca de estratégias de intervenção que poderão auxiliar na prevenção ou redução da incidência de violência intrafamiliar contra a pessoa idosa, bem como na criação de políticas públicas.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

O estudo será de caráter descritivo, exploratório, de abordagem qualitativa e de cunho transversal. O estudo será realizado no município de Três

Palmeiras, localizado ao norte do Rio Grande do Sul. Segundo dados do IBGE (2022), o município possui 4.716 habitantes, sendo destes, 1.002

pessoas que possuem 60 anos ou mais. No entanto, junto a base de dados do sistema de saúde municipal, o município possui 5.307 habitantes

cadastrados no eSUS, dentre esse montante, 1.381 são pessoas idosas. Destas, 718 do sexo feminino, 660 do sexo masculino e três pessoas

identificadas como sexo não informado. Resultando em 26,0% da população do município com mais de 60 anos. No que diz respeito ao atendimento

realizado pelo SUS, o município possui um ambulatório municipal localizado no centro da cidade e uma Unidade Básica de Saúde, localizada no

Distrito da Vila Progresso. Quanto aos profissionais que atendem no SUS, atualmente o município possui: dois psicólogos, um nutricionista, três saúde bucal, dois dentistas, sete agentes comunitários de saúde, um auxiliar de enfermagem, onze técnicos de enfermagem, dois fisioterapeutas, sete enfermeiros, um farmacêutico, um técnico de farmácia, um assistente social e seis médicos. Quanto a Política de Assistência Social, que são

serviços ofertados pelo SUAS, o município possui um CRAS, o qual é estruturado em Proteção Social básica, ofertando os serviços do Programa de

Atendimento Integral à Família (PAIF) e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Endereço: BR 285- Km 292 Campus I - 4º andar Centro Administrativo

Bairro: São José **CEP:** 99.052-900

UF: RS **Município:** PASSO FUNDO

Telefone: (54)3316-8157

E-mail: cep@upf.br

UNIVERSIDADE DE PASSO
FUNDO / PRÓREITORIA
ACADÊMICA-PROACAD/UPF



Continuação do Parecer: 7.250.207

(SCFV). Quanto aos profissionais do SUAS, o município possui atualmente: uma assistente social, uma psicóloga, duas oficinas, uma coordenadora e uma entrevistadora do Cadastro Único. Os profissionais dos demais órgãos de proteção, o estudo abrangerá os profissionais que atuam na Delegacia de Polícia e Judiciário, esses ficam lotados no município de Ronda Alta, sendo a comarca de referência para o município de Três Palmeiras, destes profissionais, será encaminhado o questionário semiestruturado para as autoridades de cada órgão. Os participantes do estudo serão de ambos os sexos, com idade acima de 18 anos e que não estejam de férias, licença ou tratamento de saúde. Inicialmente será realizado contato telefônico e encaminhado via e-mail a carta de anuência para as autoridades, posteriormente, diante da autorização, será enviado por e-mail e ou whatsapp o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A) e o questionário semiestruturado (Apêndice B), desenvolvido pela ferramenta Google Forms, relacionado aos dados sociodemográficos e específicos para responder aos objetivos do estudo, com perguntas de múltipla escolha e perguntas abertas, possibilitando que o profissional discorra livremente sobre suas percepções referentes a temática. O questionário semiestruturado, constituído por perguntas de múltipla escolha e perguntas abertas, possibilita ao pesquisador explorar as respostas direcionadas, quanto aos aspectos aprofundados e subjetivos. No TCLE apresentado no formulário Google Forms, os participantes receberão informações sobre a importância da pesquisa, objetivos, benefícios, bem como os riscos de ocorrer algum desconforto psicológico. Também será esclarecido sobre a possibilidade de desistência a qualquer momento e a garantia de sigilo quanto às informações prestadas. Frente a concordância em participar da pesquisa, será solicitado o preenchimento do questionário no formulário Google Forms.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Vide conclusões e pendências.

Recomendações:

Após o término da pesquisa, o CEP UPF solicita: a) A devolução dos resultados do estudo aos sujeitos da pesquisa ou a instituição que forneceu os dados; b) Enviar o relatório final da

Endereço: BR 285- Km 292 Campus I - 4º andar Centro Administrativo
Bairro: São José **CEP:** 99.052-900
UF: RS **Município:** PASSO FUNDO
Telefone: (54)3316-8157 **E-mail:** cep@upf.br

**UNIVERSIDADE DE PASSO
FUNDO / PRÓREITORIA
ACADÊMICA-PROACAD/UPF**



Continuação do Parecer: 7.250.207

pesquisa, pela plataforma, utilizando a opção, no final da página [Enviar Notificação](#) + relatório final.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Diante do exposto, este Comitê, de acordo com as atribuições definidas na Resolução n. 466/12, do Conselho Nacional da Saúde, Ministério da Saúde, Brasil, manifesta-se pela aprovação do projeto de pesquisa na forma como foi proposto.

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BASICAS_DO_PROJETO_2455377.pdf	09/11/2024 15:11:13		Aceito
Declaração de Pesquisadores	declaracao_de_pesquisa_nao_iniciada.pdf	09/11/2024 15:05:49	Karine Paludo	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE.pdf	09/11/2024 15:04:33	Karine Paludo	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	PROJETO_DE_PESQUISA_COMPLETO.pdf	09/11/2024 15:03:52	Karine Paludo	Aceito
Folha de Rosto	folha_de_rostoassinadaassinada.pdf	09/11/2024 15:02:00	Karine Paludo	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

PASSO FUNDO, 27 de Novembro de 2024

Assinado por:
Daniela Bertol Graeff
(Coordenador(a))

Endereço: BR 285- Km 292 Campus I - 4º andar Centro Administrativo

Bairro: São José **CEP:** 99.052-900

UF: RS **Município:** PASSO FUNDO

Telefone: (54)3316-8157

E-mail: cep@upf.br

Anexo B. Autorização para Realização da Pesquisa Fórum



Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

Vara Judicial da Comarca de Ronda Alta

Rua Duque de Caxias, 50 - Bairro: Centro - CEP: 99670000 - Fone: (54) 304-69892 - E-mail: ffrondaltavjud@tjrs.jus.br

Autorização Institucional

Eu, Carlos Alberto Janich, responsável pela(o) Cartório Judicial de Ronda Alta, RS, no exercício do cargo de Analista Judiciário, Gestor da Vara, declaro que fui informada(o) dos objetivos e procedimentos da pesquisa e concordo em autorizar a execução da mesma nesta instituição. Declaro também, que não receberemos qualquer pagamento por esta autorização, bem como também os participantes não receberão qualquer tipo de pagamento por sua participação na presente pesquisa.

Conforme Resolução CNS 466/12 pesquisa só terá início nesta instituição após apresentação do Parecer de Aprovação por um Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos.

Ronda Alta, 07 de novembro de 2024

Assinatura manuscrita em azul de Carlos Alberto Janich.

Carlos Alberto Janich
Mat. 12900482
Escritor

Anexo C. Autorização para Realização da Pesquisa Delegacia de Polícia
Civil



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
POLÍCIA CIVIL
DELEGACIA DE POLÍCIA DE RONDA ALTA

Autorização Institucional

Eu, Leandro Evandir Guimarães Antunes, responsável pela Delegacia de Polícia de Ronda Alta, no exercício do cargo de Delegado de Polícia, declaro que fui informado dos objetivos e procedimentos da pesquisa e concordo em autorizar a execução da mesma nesta instituição. Declaro também, que não receberemos qualquer pagamento por esta autorização, bem como também os participantes não receberão qualquer tipo de pagamento por sua participação na presente pesquisa.

Conforme Resolução CNS 466/12 pesquisa só terá início nesta instituição após apresentação do Parecer de Aprovação por um Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos.

Ronda Alta, 07 de novembro de 2024.

Leandro Evandir Guimarães Antunes,
Delegado de Polícia.

Anexo D. Autorização para Realização da Pesquisa Prefeitura Municipal de
Três Palmeiras



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PALMEIRAS

Autorização Institucional

Eu, Claumir Cesar de Oliveira, no exercício do cargo de prefeito municipal declaro que fui informado dos objetivos e procedimentos da pesquisa e concordo em autorizar a execução junto as secretarias de Promoção Social e Saúde. Declaro também, que não receberemos qualquer pagamento por esta autorização, bem como também os participantes não receberão qualquer tipo de pagamento por sua participação na presente pesquisa.

Conforme Resolução CNS 466/12 pesquisa só terá início nesta instituição após apresentação do Parecer de Aprovação por um Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos.



Três Palmeiras, 10 de outubro de 2024

Adm. 2021/2024

Praça 12 de Maio, 763 - Fones: (54) 3367-1040 - CEP: 99.675-000 - CNPJ: 92.399.112/0001-85



**PREFEITURA DE
TRÊS PALMEIRAS**
Compromisso para continuar



UPF
UNIVERSIDADE
DE PASSO FUNDO

UPF Campus I - BR 285, São José
Passo Fundo - RS - CEP: 99052-900
(54) 3316 7000 - www.upf.br